

⇒신경정신과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: **파랑**
- 강조: **빨간색** 밑줄
- 말없이 지나간 부분 OR 교과서 내용: 회색
- 이번주차는 ADHD까지 6가지 강조하셨고, 품행장애부터는 가볍게 보시면 됩니다.
(이 써머리 기준 p23까지 열심히 보면 됨)

[1] 소아, 청소년 정신장애에 대한 동,서의학적 이해

[DSM-4] 유아기, 소아기, 청소년기에 흔히 처음으로 진단되는 장애	[DSM-5] 신경발달장애 Neurodevelopmental disorders
1. 정신지체 2. 학습장애 3. 운동기술장애 4. 의사소통장애 5. 전반적 발달장애 6. 주의력 결핍 및 파괴적 행동장애 7. 유아기 또는 초기 소아기 급식 및 섭식장애 8. 틱장애 9. 배설장애 10. 기타 소아관련 장애	1. 지적장애 2. 특정 학습장애 3. 의사소통장애 (언어장애, 발화음장애, 아동기발생 유창성장애, 사회적 의사소통장애) 4. 자폐스펙트럼장애 (ASD) 5. 주의력 결핍/과잉행동 장애 (ADHD) (부주의우세형·과잉행동·충동성우세형·합쳐진 유형) 6. 운동장애 1) 발달적 운동조정 장애 2) 정형적 동작장애 3) 틱장애 -뚜렛장애 -만성운동or음성 틱장애 -일시적 틱장애

DSM-4의 파괴적 행동장애, 섭식장애, 배설장애는 DSM-5에서 다른 분류로 이동됨
 교과서가 DSM-4기준으로 되어있기 때문에 수업은 DSM-4의 순서를 따라 진행되지만 DSM-5
 기준으로 알아두는 것이 중요하다!
 (정신과 씬부를 힘드게 하는 이유.. DSM 5 나온지가 10년이 넘었는데 교과서는 언제 바뀌는지..)
 오늘 수업은 DSM-5에 나오는 6가지 위주로 기억하기!
 씬부: 위 표와, 각 절의 맨 처음 등장하는 (교과서와) DSM4와 5 차이 표를 계속 참고하면 오늘
 수업 내용이 이해가 잘 됩니다~

0절. 개요

소아청소년의 정신장애

- 전세계 소아 청소년 중 10-20%가 정신장애 경험
- 소아청소년 정신장애 사례 중 1/2가 14세 이전에 시작
- 치료를 받지 않으면 아동의 발달, 교육 성취도, 생산적인 삶을 살 수 있는 잠재
력에 심각한 영향을 미친다.
- 정신장애가 있는 아동은 낙인, 고립, 차별, 의료 및 교육 시설에 대한 접근성
부족 등, 아동의 기본 인권을 침해하는 주요한 문제에 직면하고 있다.

신경발달장애(Neurodevelopmental Disorders) 개요 ★

- 뇌의 발달지연, 손상 등과 관련된 정신장애로서 유아기, 아동기와 관련이 깊음
- 원인은 심리사회적 문제보다 **뇌의 발달문제와** 관련이 깊음

지적(발달)장애	지능이 비정상적으로 낮아서 추리, 문제해결, 계획, 추상적 사 고, 판단력, 학습능력과 같은 정신활동에 제약 이 있고 개인적, 사회적 적응기능에 큰 어려움. IQ 70이하
특정 학습장애	지능과 신체상태가 정상이나 읽기, 쓰기, 산술과 관련 기술을 학습하는데 현저한 장애
의사소통장애	지능은 정상이나 말이나 언어의 사용에 결함이 있는 장애
	① 언어 장애 :이해력이나 표현력 결함 때문에 언어의 습득과 사용에 지속 적인 곤란을 나타내는 장애
	② 발화음 장애(발음장애, 발성장애, 구음장애, 음성학적 장애) : 발음의 지속적인 곤란 때문에 언어적 의사소통에 지장이 초 래되는 장애
	③ 아동기발생 유창성장애(말더듬기) : 말을 더듬기 때문에 언어의 유창성에 지장이 초래되는 장애
자폐스펙트럼장 애	④ 사회적 의사소통장애 dsm5에서 추가됨 : 언어적 및 비언어적 의사소통 기술의 사회적 사용 에 지속적 인 곤란을 나타내는 장애
	사회적 상호작용과 의사소통에 심각한 어려움, 관심과 흥미의 범위 매우 제한적, 기이하고 상동증적인 행동 반복

주의력 결핍/ 과잉행동장애 (ADHD)	자신의 행동을 적절하게 통제하지 못하고, <u>부주의</u> , <u>충동적인 과잉행동</u> 을 나타내는 장애. 부주의 우세형 /과잉행동-충동성 우세형 / 이 2개의 증상군이 합쳐진 유형
운동장애	나이나 지능에 비해 기대되는 수준보다 움직임이나 운동능력이 현저하게 미숙하거나 부적응적인 움직임을 반복적으로 나타내어 일상활동에 심각한 지장을 초래
	① 발달성 운동협응장애 : 앉기, 서기, 걷기, 뛰기 등의 운동발달이 늦고 운동협응 능력에 결함이 있기 때문에 동작이 서툴러서 일상 활동에 뚜렷한 지장이 초래되는 장애
	② 상동증적 운동장애 : 비기능적이고 비효율적인 특정한 패턴의 행동을 아무런 목적 없이 반복적으로 지속하여 부적응이 초래되는 장애
	③ 틱장애 얼굴근육이나 신체의 일부를 불수의적으로 갑작스럽고 빠르게 움직이는 행동을 반복하거나 소리를 내는 부적응적 행동의 장애 가. 뚜렛장애 : 다양한 운동틱과 음성틱이 1년 이상 지속적으로 나타나는 경우 나. 만성운동 또는 음성 틱장애 : 운동틱이나 음성틱이 1년이상 나타나는 경우 다. 일시적 틱장애 : 운동틱이나 음성틱이 1년미만 나타나는 경우

유아기, 아동기, 그리고 청소년기 발달

배아기 Prenatal	수정~8주	걸음마기 toddler period	15개월~2년반
태아기 Fetus	8주~출생전	학령전기 preschool period	2년반~6년
영아기 Infancy	출생~15개월	학령기/소아기 middle years	6년~12년

✓ adverse childhood experiences (ACEs)

- 부정적인 소아기 경험은 개인발달을 바꾸고, 초기 뇌 발달기간동안의 부정적인 경험은 특히 장애에 취약함

아래표는 참고만 (노란색 친 부분만 짧게 언급하고 넘어감)

발달단계	영아기(0~12개월)	걸음마기(1~3세)	학령전기(4~6세)	학령기(7~12세)
대운동	뒤집기-기기-서기	혼자 걷고, 뛰고, 던지고 공차기-세발자전거 대소변가림	한쪽 발로 뛰기-줄넘기 가위질	구기운동(야구, 축구 등) 자전거 타기
소운동	장난감 잡고 흔들기 연필로 끌적 거리기	동그라미(2세) 십자가(3세) 토막 6개 쌓기(2세)	사각형(4세) 다이아몬드(6세) 사람그림(4세-3부분, 5세-6부분)	다양한 그림 모형 제작
인지 언어	용알이(3~4개월) 숨은물건 찾기(8개월) 말뜻이해(손가락으로 가리킴)	말 시작-단어 이해 “엄마, 아빠” 등 돌전후 첫단어 2세 말:2~3단어 문장 , 200단어	언어의 급성장-의지대로 이야기, 말장난 상상, 공상	공부, 운동, 게임 지적, 신체적 기술 연마 논리적 사고-의미 글쓰고 읽기
정서, 사회적 행동	사회성 미소(2개월) 눈맞춤(1개월) 엄마에 대한 변별화 반응(6개월) 호혜적 관계 형성(애착)(6~12개월) 분리불안-외인불안(6~8개월) 엄마나 주위 사람 눈치 봄	자기주장-부정적 태도 엄마와 힘겨루기 안되면 생떼, 공격행동 능동적으로 주위 탐색	아빠-엄마 관계 관찰 성에 관심, 성역할 모방 또래와 어울리고 협동 놀이 공포-귀신, 괴물, 도깨비 다양한 활동으로 전통, 습관, 가치관 습득 공감력	이타심 질서의식 단체행동

	영아기(0~12개월)	걸음마기(1~3세)	학령전기(4~6세)	학령기(7~12세)
발달과제	엄마와의 애착 형성 기본적 신뢰감, 안정감 엄마가 안전기지 신체, 중추신경계 성숙	공격성, 충동의 통제 자율성-개체성 자기주장-자아통제 자아의 분리, 개별화	남녀 성 역할 학습 주도성-목적의식 사회적 역할 학습 전통, 문화적 가치관 습득	우정, 또래관계 수립 생산성-근면성 효능감, 자존감 기초 학습능력 습득
정신성 발달 Freud	구강기	항문기	남근기	잠복기
정신사회발달 Erikson	기본적 신뢰 vs 불신	자율성 vs 수치심, 의욕	주도성 vs 죄책감	근면성 vs 열등감
관련 정신병리	수유장애, 영아 colic 수면장애 발육부진 모성결핍 아동학대, 방임 반응성 애착장애 자폐장애 정신지체 뇌손상	과잉보호, 과잉통제 이식증-반주 심한생떼, 공격성 반대적, 반항장애 공생 정신병 자폐장애 전체발달지연 언어발달지연	분리불안증, 공포증 유뇨증 유분증 약용, 야경증 과잉운동증 발달성 언어장애 비사회화 공격성 자위행위	열등의식, 낮은 자존감 학습부진, 특수학습장애 불안장애 (분리불안, 과잉불안) 우울장애, 신체화장애 강박장애, 틱장애 몰행장애, 반항장애 주의력결핍과잉운동장애 아동기 정신분열 등교 거부증

애착이론 Attachment

✓ 프로이드

- 어머니-자녀관계의 '의존성' 개념
- 기본 생리적 욕구의 만족을 통해 획득되는 2차적인 것

✓ Harlow & Zimmerman의 원숭이 실험

- 우유를 제공하는 철사 대리모 vs. 우유를 제공하지 않는 천 대리모
- 대부분의 시간을 천대리모에 매달려 지냄
- 접촉을 통한 위안과 사랑이 애착형성에 큰 영향을 미친다.

✓ Dr. Spitz의 시설아동에 대한 처방

- 세계 2차 대전 이후 많은 전쟁 고아들이 시설에서 생활
- 시설은 매우 청결, 영양식 공급하였으나 아이들은 '성장 실패'

반면 시설과 영양 면에서 더 떨어지는 멕시코의 한 병원에서는 아이들이 건강하게 지냈는데 동네 부인들이 아이들과 잘 놀아주고 안아주었기 때문이었다.

- Spitz 박사의 처방: "일대일 관계에서의 부드럽고 사랑에 찬 보살핌"
- 정서적 양육은 건강한 심리발달, 삶 자체에 핵심적

✓ 애착이란?

- Bowlby(1958) : '애착(attachment)'이라는 용어를 사용
- 다른사람에게 접근추구를 하고 접근유지를 하려는 행동이며, 가장 가까운 사람과 연결되게 하는 강렬하고도 지속적인 정서적 결속
- 특정인과 형성하는 능동적인 정서적 유대관계로, 상호작용적이며 지속적인 관계를 통해 두 사람 간의 결속을 강화하는 것

영아기 애착 유형 분류

✓ 안정형 secure attachment

- 분리시 울 수도 안울 수도 있으나, 재결합시 보호자와 긍정적인 상호작용을 회복
- 운다 하더라도 쉽게 진정되고 빠른 시간 내에 주변의 놀이 환경을 탐색한다.
- 어머니: **아기의 요구, 신호에 민감하게 반응하고 스스로 노는 것을 충분히 허용**
- **일관되고(consistent), 민감하게(sensitive), 반응한다(responsive)**
- 영아:필요할 때 엄마가 위로해 줄 수 있다는 것을 기대하므로 다시 탐색으로 돌아감
- 대인관계 신호에 대해 예언적이고 의사소통적 가치를 학습

✓ 회피형 avoidant attachment

- 보호자가 떠나는 것에 저항X, 재결합시 보호자에 관심이 없고 외부환경에 초점
- 어머니: **아기의 요구에 무감각하며, 신경질적, 거부적**
- 과 자극적일 경우, 아기의 쉬고 싶은 욕구에 민감하게 반응적이지 못함
엄마의 투머치한 관심으로 인해 회피반응으로 혼자 있고 싶은 수도 있음
- 영아: 엄마의 거부와 화내는 것을 막기 위해 애착행동이 억제되어 있다.
- 속으로는 불안하고 엄마의 동태를 살피면서도 애착 행동을 표현하지 못한다.
(어머니와의 분리에서 받는 스트레스에 대한 전략을 회피반응으로 나타내기 때문)
- 탐색활동이 적절히 이루어지지 못함
- 감정적 신호를 사용하거나 해석하지 않고 인지적 정보를 이용하여 행동을 조직화(회피)
- 감정표현, 타인 감정의 해석이 안됨(inhibition) -> 생각(눈치)하여 행동(인지적 조절강화)

✓ 저항형 resistant attachment

- 분리시 심하게 울고, 재결합시 보호자에게 접근하지만 위로받을 때 저항하고 쉽게 진정되지 않고, 안정되어 놀이로 돌아오는데 오랜시간 걸린다. (화내기, 울기, 발차기, 분노로 바닥에 엎드리기 등)
- 어머니: 비밀관적 양육행동으로, 아이의 욕구를 무시하다 기분이 내키면 들어줌
- 영아: 애착행동이 강화되어 있다.
- 언제 보일지 모르는 양육자의 반응을 끌어내기 위한 과장된 애착행동 전략
- 엄마가 어떤 반응을 보일지 예측하기 어려우므로 미리 생각하지 못함
- 감정적 정보에만 의존한다(감정에 휩싸임)
- 화내고, 그러고나면 거부당할까 두려워 엄마에게 아부하는 등 양가적이다.
- 엄마에 집착되어 있어서 환경을 탐색하지 못한다.

✓ 혼돈형 disorganized/ disoriented attachment

- 보호자의 위로를 얻기위한 전략을 완성하지 못하거나 혼란스러운 경우
- 재결합시 상반된 행동패턴을 잇달아 혹은 동시에 나타냄 (강한 애착행동이나 분노표현, 안겼다가 밀어버림. 얼어붙거나 멍한 행동, 표정 불일치)
- 생소한 상황에서 애착대상과의 이별과 재회를 소화하기 위한 행동전략이 X
- 어머니: 본인이 해결안된 상실, 외상을 경험하거나 정신장애(우울증, 알콜중독)시 아동을 방치, 학대
- 영아: 접촉에 대한 욕구는 강하나, 버림받고 구박받은 데에서 오는 공포가 공존
어머니의 frightening/frightened behavior 때문

1절. 지적장애 Intellectual disability

DSM-IV-TR Mental retardation	DSM-5 intellectual disability
A. 심하게 평균수준 이하인 지적 기능: 개별적으로 실시된 지능 검사에서 70 이하의 지능지수(유아의 경우는, 지적 기능이 유의하게 평균 이하라는 임상적 판단) B. 다음 항목 중 적어도 두 가지 항목에서 현재의 적응기능결함이나 장애를 동반한다: 의사소통, 자기돌봄, 가정생활, 사회 및 대인관계 기술, 지역공공시설의 활용, 자기관리, 학업, 직업, 여가선용, 건강 및 안전 C. 18세 이전에 발병한다. 지능장애의 수준을 반영하는 심각도에 근거한 분류 경도 지적장애: 50-55에서 약 70까지 중등도 지적장애: 35-40에서 약 50-55까지 고도 지적장애: 20-25에서 약 35-40까지 최고도 지적장애: 20-25 이하 불특정 지적장애	지적장애(지적발달장애)는 발달시기에 시작되며, 개념, 사회, 실행 영역에서 지적 기능과 적응 기능 모두에 결함이 있는 상태를 말한다. 다음의 3가지 진단기준을 충족해야 한다. A. 임상적 평가와 개별적으로 실시된 표준화된 지능 검사로 확인된 지적기능(추론, 문제해결, 계획, 추상적 사고, 판단, 학업, 경험 학습)의 결함이 있다. B. 적응 기능의 결함으로 인해 독립성과 사회적 책임 의식에 필요한 발달학적, 사회문화적 표준을 충족하지 못한다. 지속적인 지원 없이는 적응 결함으로 인해 다양한 환경(가정, 학교, 일터, 공동체)에서 한 가지 이상의 일상활동(의사소통, 사회적 참여, 독립적 생활) 기능에 제한을 받는다. C. 지적 결함과 적응기능의 결함은 발달시기 동안에 시작된다. 경도 중등도 고도 최고도

DSM4에서는 정신지체라고 했다.

DSM4에서는 지능지수만 봤는데 DSM5에서는 지적기능과 적응기능을 같이 본다.

지적기능: 추론, 문제해결, 계획, 추상적 사고, 판단, 학업, 경험학습

적응기능: 가정, 학교, 지역사회 등 다양한 환경에서 의사소통이나 사회적 참여, 독립적 생활 등 일상생활을 영위하는 능력.

DSM4: 18세 이전에 발생한다 -> DSM5: 발달시기 동안에 시작된다.

심각도 수준

	경도	중등도	고도	최고도
IQ	50-69	35-49	20-34	20미만
비율	70-85%	10-20%	3-4%	1-2%
별칭	교육가능급	훈련가능급	완전보호급	
장애등급	3급	2급	1급	
정신연령	9-12세(6학년)	6-9세(2학년)	3-6세	3세 미만
독립	원조만 필요 비숙련 직업가능	높은 수준의 감독보호 하 작업	완전한 감독 옷, 식사, 배설 가능	기본생활, 신변에 지속적 간호 필요

역학

- 전체 인구 중 약 1-2%의 유병률
- 전체적으로 남자에게 더 흔함(60%정도)
 - 중증/최중증 지적장애는 남녀 비슷한 유병율
- 발병율이 최고치에 도달하는 시기는 10~14세임.
 - 소아기까지 경도 지적장애는 진단이 어려워 정확한 발병율을 측정하기 어려움
 - 어떤 경우에는, 지적능력이 제한이 있더라도, 사회적 적응 기술에는 초기 청소년기까지 어려움이 없을 수 있어, 진단이 그 시기까지 내려지지 않을 수 있음.

병리

- 30~40% 정도가 원인 불명
- 지적장애가 심할 수록 분명한 원인이 발견되는 경우가 많다.
- 생물학적 원인
- 환경적 또는 사회경제적 원인
 - 산전의 적절한 의학적인 검사 부족, 영양상태의 불량 가능성
 - 10대 임신 → 산과적 합병증의 위험성, 미숙아, 저체중아 가능성 증가
 - 산후 산모에 대한 불량한 의학적 배려
 - 유아의 영양불량
 - 독성물질 또는 외상 등에 노출된 위험성
 - 가족내에 불안정성, 잦은 이사, 부적절한 보살핌
 - 어머니의 교육정도가 낮아 아이에게 충분한 자극X
 - 절대빈곤층, 사회경제적으로 낮고 불우한 계층에서 교육,경험부족
 - 아동학대 및 방임의 장기간 경험

공병

- 정신장애 유병율은 일반인보다 최소 3~4배 높음
 - 중증 지적장애자는 약 50%에서 다른 정신장애 공병
- 흔히 볼 수 있는 정신장애
 - 주의력결핍/과잉행동장애
 - 자폐장애
 - 상동행동장애

- 이식증(pica)

- 과잉활동증상, 좌절에 대한 낮은 내성, 공격적인 행동, 분노발작, 정서불안, 상동적인 행동, 자해적인 행동
 - 자해적인 행동은 지적장애가 심해질수록 더 자주, 더 심함.
- 성충동 조절능력, 판단력의 미숙으로 성적 탈선이나 성범죄율이 높음

분류

1) 경도 지적장애 (IQ 50~70)

- 전체지적장애의 85%
- 교육가능군: 초등학교 6학년 수준까지 교육가능함.
- 학교에 입학할 때까지 진단이 내려지지 않을 수 있음.
 - 대인관계를 맺는 능력이나 언어발달상태가 학령전기에서는 크게 문제가 되지 않을 수 있으며, 감각운동기능에 있어서도 최소한의 장애만이 동반되기 때문임.
 - 나이가 들수록 추상적 사고능력의 결핍과 자기중심적인 사고 등으로 인해 또래 아이들과 구분됨
- 성장하여 획득한 직업적인 기술로 혼자서 살아갈 수 있지만, 스트레스 하에서는 도움이 필요

2) 중등도 지적장애 (IQ 35~50)

- 전체지적장애의 10%
- 직업훈련군: 초등학교 2학년 수준까지 교육가능함.
- 경도의 지적장애보다는 더 어린 나이에 진단이 내려짐
 - 언어발달이 더 느리고 초등학교에서부터 대인관계의 발달이 문제가 되기 때문
- 직업훈련에 의하여 도움을 받을 수 있고 적절한 감독을 받으면 스스로 돌볼 수 있는 능력을 갖출 수도 있음.
 - 비교적 높은 수준의 감독이 계속 요구되지만 도움을 받는 상황에서는 직업적 업무를 적절히 수행가능
- 익숙한 장소에 대해서는 혼자서 여행하는 것도 가능할 수 있음
- 자신의 부족한 점을 알고 있으며, 종종 그들의 친구들로부터 거리감을 느끼고 자신의 한계 때문에 좌절하기도 함

3) 중등 지적장애 (IQ 20~35)

- 전체지적장애의 3~4%
- **보통 학령전기에도 진단 가능함**
-언어발달이 일어나지 않거나 극도로 제한되어 있고 운동의 발달에 심한 지연이 있기 때문
- 학령기가 되면 약간의 언어발달이 일어나며, 스스로 돌볼 수 있는 기본적인 능력은 어느정도 갖출 수 있음.
- 학습능력은 가, 나, 다 정도나 간단한 셈은 가능하며,
- 성인이 되면 철저한 감독 하에 간단한 일은 할 수 있음

4) 최중증 지적장애 (IQ 20미만)

- 전체지적장애의 1~2%
- 지속적인 감독이 필요하며 언어나 운동발달에 심한 장애가 동반됨
- 성인이 되면 약간의 언어 발달과 간단한 자조능력은 갖추게 되나
- 독립적인 생활은 어려우며 타인의 도움이 필요함

지적장애 소아, 청소년의 발달학적 위기

• 부정적 자아 개념

학령기	• 경한 지적장애 소아들은 자신 연령에 적합한 기대를 하지만 실제로 충족시킬 수 없어 행동적 문제로 발전하기도 함 • 적절한 지지와 준비가 없는 포괄적 과정은 불안, 우울, 행동적 문제를 초래 학습은 정상아동과 통합된 환경에서 더 잘할지는 모르지만, 사회적 과정은 교사뿐만 아니라 동료들에 의한 수용성이 좋지 않다면 손상 받을 수 있음.
청소년기	• 장애가 덜한 소아 청소년들이 더 불리한 조건에 놓여있을 수 있음 (결점을 더 잘 알고 있고, 비적응적 방어를 적용한다는 것을 잘 알고 있기 때문) • 의사소통, 인지적, 추상적 기술이 요구되는 그룹의 상호작용에 참여시키기 더욱 어려움 • 긍정적인 자아상을 발전시키도록 도움을 주는 것으로 시작하고,

	사회적 상호작용 기술을 가르치고, 궁극적으로 성에 관해서 가르침
--	--

소아 지적장애에 대한 부모의 반응과 적응

진단에 대한 초기 반응	• 부모들이 동의하기에 매우 괴로움 • 부모의 걱정에 공감과 귀를 기울여야 함 • 이용할 수 있는 서비스와 부모들이 소아발달을 향상시킬 수 있는 것에 대한 상세하고 도움이 되는 정보 제공해야 함. • 부모들은 지적장애 소아 출산에 대한 우울한 반응 부모의 슬픔은 단지 병적 우울이 아니라 적응반응이며, 만성적인 슬픔임. 충격, 부인, 분노, 슬픔, 재구조화, 적응.
초기이후의 적응	• 도움을 줄 수 있는 전문가의 접근과 지지망의 이용 • 4가지 측면에서 필요한 지원 고려 - 지적기능과 적응기술 - 심리적 기능과 정서적 기능 - 신체적 기능과 건강 - 현재의 환경과 지속적인 성장에 가장 바람직한 환경

진단

- (1) 과거력
- (2) 정신과적 면담
- (3) 구조화된 도구를 이용한 검사
 - 인지기능

6~16세	웍슬러 지능검사
3~6세	Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised
2세~	Stanford-Binet Intelligence Scale, Fourth Edition
2.5~12.5세	The Kaufman Assessment Battery for Children
11~85세	Kaufman Adolescent and Adult Intelligence Test

- 적응기능 : 의사소통, 일상생활, 사회화, 운동능력

*신생아~18세까지 Vineland Adaptive Behavior Scales 이용

- 행동검사 등

(4) 신체검사: 주산기나 산전의 이벤트, 환경

(5) 신경학적 검사

- 감각기능장애 검사

청력소실은 지적장애의 10%에서 발견됨

- 전체 지적장애의 10%에서, 중증 지적장애의 1/3에서 간질발작 발견

- 운동기능장애 검사

:muscle tone(spasticity or hypotonia), reflexes(반사과다), involuntary movements(무도무정위운동 등)

감별진단

- 감각기능 장애:감각기능(청력, 시력)의 문제인지 모르면 지적장애로 오인할 수 있음

- 표현성, 수용성 언어장애

- 뇌성마비 cerebral palsy

- 만성신체질환을 앓는 아이

- 발작장애 Seizure disorders

- 기질성질환으로 난독증(alexia), 실서증(agraphia), 실어증(aphasia)가 동반된 경우

:다른 영역에서는 정상발달하지만, 지적장애의 경우에는 모든 분야에서 발달이 느림

- ASD (autism spectrum disorder, 자폐스펙트럼 장애), 경계선 지적 기능

ASD	• 지적장애의 70~75%에서 ASD가 공병 • ASD환자의 19.8%에서 지적장애를 갖고 있음 • ASD를 공병하는 아동은 동일한 수준의 지적장애아동보다 사회적 관계와 언어에 상대적으로 더 심각하게 저하
경계선 지적 기능	• 지능지수가 71~84인 경우 • 검사의 조건에 따라서 5점 정도의 오차가 있을 수 있기 때문에 지능지수가 71~75사이라고 하더라도 적응능력이 뚜렷한 장애가 있을 때에는 지적장애라는 진단이 가능함

경과와 예후

- 대부분의 지적장애에서 지적인 기능 자체는 호전되기 어려움

- 기저의 지적능력저하가 호전되지 않더라도, 대부분의 지적장애에서 지지적이고 좋은 환경이 주어지면 나이가 들어감에 따라 적응 수준이 향상될 수 있음

-특히 경도지적장애는 조기에 적절한 교육을 받으면 상당한 수준의 적응상태를 기대할 수 있음.

- 동반 정신과적 장애가 있는 경우에는 일반적으로 예후가 불량함

치료

- 지적장애에 대한 최선의 치료는 예방

- 공병하는 정신과적 장애에 따라 특정 치료가 필요함.

1차적 예방	지적장애와 관련된 질환을 발생시키는 상황을 줄이는 과정 - 지적장애 관련된 유전질환의 가족력이 있는 가계에 대한 상담 - 사회경제적 수준이 낮은 계층에 대한 산후 관리
2차적 예방	조기발견, 조기치료
3차적 예방	재활로서 후유증이나 잔류 장애를 최소화

- 소아에 대한 교육

- 적응기술훈련, 사회성증진훈련, 직업훈련 등 포괄적인 특수교육 프로그램이 필수적

- 행동치료: 사회적 행동을 늘리고, 공격적이고, 파괴적인 행동을 줄이는 데 유용함.

- 가족에 대한 교육

- 환자에 대한 현실적인 기대를 유지시키면서, 환자의 능력과 자존심을 향상시킬 수 있는 중요한 방법

- 흔히 가족들은 어느 정도로 환자의 독립을 촉진시키면서 동시에 보호를 마련해야 할 지 판단이 어려운 경우가 많다.

-이러한 문제에 대해 지속적으로 상담 또는 가족치료를 함으로써 부모에게 도움을 줄 수 있음

- 부모 자신의 죄책감, 낙심, 분노 등의 감정을 표현할 수 있는 기회 제공

2절. 학습장애 Learning Disorders

교과서	DSM-4 유아청소년기에 처음 진단되는 장애	DSM-5 신경발달적 장애
1. 정신적 발달장애 2. 학업능률의 특수발달 장애 1) 특수 읽기장애 2) 특수 철자장애 3) 특수 산술장애	학습장애 • 읽기 장애 • 산술 장애 • 쓰기 장애 • 상세불명의 학습장애	특정 학습 장애 • 읽기 장애 • 산술 장애 • 쓰기 장애

학습장애, 학습지진, 학습부진

학습장애	- 넓은의미: 지적장애나 뇌손상 혹은 정서적 문제 등을 포함한 어떠한 요인에 의해서건 학습에 어려움을 보이는 경우 - 좁은의미: 정상지능을 가진 아동이 학업적 기술을 학습하는 데 실패한 경우 =잠재적 학습능력과 실제 학업 성취간의 심각한 불일치를 보이는 경우 <u>언어적 또는 비언어적 정보의 습득, 조직화, 유지, 이해, 사용 등에 영향을 미치는 여러 가지 장애</u> 학습의 어려움이 감정문제, 문화적 차이, 기회박탈, 장애(신경, 발달, 운동, 감각 등) 등에 의해 오는 경우가 아님.
학습지진 slow learner	학업실패가 낮은 지능 에 기인한 경우
학습부진 under achievement	우울, 불안과 같은 정서적 문제 에 기인되어 학습에 어려움

[DSM-5] 특정학습장애 (참고)

- A. **학습 기술을 배우고 사용하는 데 있어서의 어려움**
이러한 어려움에 대한 적절한 개입을 제공함에도 불구하고 아래에 열거된 증상 중 적어도 한 가지 이상이 최소 6개월 이상 지속된다.
- 부정확하거나 느리고 힘겨운 단어 **읽기**(예, 단어를 부정확하거나 느리며 더듬더듬 소리 내어 읽기, 자주 추측하며 읽기, 단어를 소리 내어 읽는 데 어려움이 있음)
 - 읽은 것의 의미를 이해하기 어려움(예, 본문을 정확하게 읽을 수 있으나 읽은 내용의 순서, 관계, 추론 또는 깊은 의미를 이해하지 못함)
 - 철자법의 어려움(예, 자음이나 모음을 추가하거나 생략 또는 대치하기도 함)
 - 쓰기**의 어려움(예, 한 문장 안에서 다양한 문법적·구두점 오류, 문단 구성이 엉성함, 생각을 글로 표현하는 데 있어 명료성이 부족함)
 - 수 감각, 단순 연산값 읽기 또는 연산 절차의 어려움(예, 숫자의 의미, 수의 크기나 관계에 대한 빈약한 이해, 한 자리 수 덧셈을 할 때 도래물처럼 단순 연산값에 대한 기억력을 이용하지 않고 손가락을 사용함, 연산을 하다가 진행이 안 되거나 연산 과정을 바꿔 버리기도 함)
 - 수학적** 추론의 어려움(예, 양적 문제를 풀기 위해 수학적 개념, 읽기된 연산값 또는 수식을 적용하는 데 심각한 어려움이 있음)
- B. 보유한 학습 기술이 개별적으로 실시한 표준화된 성취도 검사와 종합적인 임상 평가를 통해 생활연령에 기대되는 수준보다 현저하게 양적으로 낮으며, 학업적·직업적 수행이나 일상생활의 활동을 현저하게 방해한다는 것이 확인되어야 한다.
17세 이상인 경우 학습 어려움에 대한 과거 병력이 표준화된 평가를 대신할 수 있다.
- C. 학습의 어려움은 학령기에 시작되나 해당 학습 기술을 요구하는 정도가 개인의 능력을 넘어서는 시기가 되어야 분명히 드러날 수도 있다
(예, 주어진 시간 안에 시험 보기, 길고 복잡한 리포트를 촉박한 마감 기한 내에 읽고 쓰기, 과중한 학업 부담).
- D. 학습의 어려움은 지적장애, 교정되지 않은 시력이나 청력 문제, 다른 정신적 또는 신경학적 장애, 정신사회적 불행, 학습 지도사가 해당 언어에 능숙하지 못한 경우, 불충분한 교육적 지도로 더 잘 설명되지 않는다.

*주의점: 4가지의 진단 항목은 개인의 과거력(발달력, 의학적 병력, 가족력, 교육력), 학교의 보고와 심리교육적 평가 결과를 임상적으로 통합하여 판단한다.

역학과 병리

- ✓ 학습장애의 유병률은 읽기·쓰기·산술장애를 구분하지 않고 전체적으로 조사하여 각기 정확하진 않음 (약 5%)
- ✓ 읽기장애는 부주의와 관련이 있으며, ADHD가 동반되는 경우가 많음.
- ✓ 신경학적 장애, 뇌기능 장애, 유전적 요인과 관련이 있는 것으로 보고되어 왔음
 - 뇌성마비, 간질, 신경체계의 감염, 뇌손상이 있는 경우가 많음
 - 비정상적인 피질 편측화
: 난독증 환자는 좌반구가 우반구보다 기능이 결함되거나 비대칭적으로 작은 경우 有 (특히 측두 부분에서)
- ✓ 학습장애 일치를 이란성 쌍둥이 31%, 일란성 쌍둥이 70%

경과와 예후

읽기장애	- 정규 학교 교육이 시작되는 시기가 되면 뚜렷하게 나타남 - 조기치료가 시작되면 대부분 예후가 양호 → 1~2학년 말경 호전 - 지능이 좋은 경우 예후 좋음 3학년정도까지 치료가 이루어지지 않으면 읽기 능력의 장애가 성인기까지 지속될 수 있음
쓰기장애	- 일반적으로 쓰는 것을 가장 나중에 배우기 때문에 1학년 초기에는 문제가 뚜렷이 드러나지 않는 경우가 많고, 대개 1학년 말경에 문제가 분명해짐 - 심하지 않은 경우에는 5학년 정도까지 발견되지 않을 수 있음
산술장애	보통 2,3학년이 되어야 분명해짐 - 이 장애를 지닌 아동이 지능이 높다면, 저학년에서는 계산 수준이 다른 아이들과 비슷한 수준이므로 5학년이나 그 이후까지 분명하게 드러나지 않을 수 있음 적절하게 치료를 받지 않는 경우 학업을 지속하기 어렵고, 자존감 저하, 우울증 등 정서적인 문제가 생길 가능성 높음

감별진단

✓ 환경적 문화적 요인으로 인한 학습 기회 결여

- 적절하게 학습할 기회가 부여되지 않아 전반적인 학습능력이 저하되어 있는 경우

✓ 지적장애

- 지적장애를 지니는 경우, 학습에 요구되는 인지적 능력의 결함으로 인해 학습에 심한 문제를 보임.
- 경도의 지적장애에서 읽기, 쓰기, 계산하기 능력이 제공되는 학교 교육과 지적장애의 심각도에 비해 현저하게 낮은 경우가 있음 → 학습장애가 추가로 진단됨

✓ 시력 및 청력장애

- 학습능력에 영향을 미칠 수 있으므로, 청력이나 시력에 대한 정밀검사 실시
- 학습장애가 감각 결함과 함께 동반되는 경우에는 통상적인 감각 결함에 동반되는 정도보다 심한 경우에만 학습장애로 진단내릴 수 있음.

3절. 운동기능장애 Motor Skill Disorders

교과서	DSM-4 유아청소년기에 처음 진단되는 장애	DSM-5 신경발달적 장애
3) 운동기능의 특수발달 장애	운동기능장애 발달성 운동 협응장애	운동장애 - 발달성 운동 협응장애 - 상동증적 운동장애① - 틱장애② -뚜렛장애 -지속성 만성/음성 틱장애 -일시적 틱장애
- DSM-4에서는 발달성 운동 협응장애만 있음 - DSM-5에서는 틱장애와 상동증적 운동장애를 운동장애로 묶음		

- 협응된 운동의 습득과 수행이 개인의 생활연령과 기술 습득 및 사용의 기회에 기대되는 수준보다 현저하게 낮음.

-운동기술 수행(ex. 물건잡기, 가위나 식기 사용, 글씨 쓰기, 자전거 타기 또는 스포츠 참여)의 지연과 부정확성,

-서투른 동작(ex. 물건 떨어뜨리기 또는 물건에 부딪히기)

- 지적장애, 시각손상, 운동에 영향을 미치는 신경학적 상태(뇌성마비, 근육퇴행위축, 퇴행성 질환) 배제

- 발병은 아동기 초기에 시작(초기 발달시기)

유아기	몸을 뒤집거나 기어다니거나 앉거나. 서거나, 걷거나, 단추를 채우거나, 바지를 입고 지퍼를 올리는데 지장
2-4세	물건을 제대로 잡지못하고, 자주 떨어뜨리며, 걸음걸이 불안정
소아	퍼즐 맞추기 블록쌓기 게임, 공을 차고 놀거나, 글씨를 쓰거나 그림을 그리는 것 잘 안됨 경과는 다양하나 적어도 1년간 추적관찰에서는 안정적임.

- 아동의 50~70%에서 운동 협응 문제가 청소년기까지 지속됨
- 공병(Comorbidity): 언어장애, 특정학습장애. ADHD, 자폐스펙트럼장애, 파괴적, 감정적 행동

상동증적 행동 장애 Stereotypic Movement Disorder ①

- 특정 행동패턴을 아무 목적 없이 반복, 지속하여 부적응 문제가 발생하는 경우
- 손 흔들기, 몸을 좌우로 흔들기, 머리흔들기, 손가락 깨물기, 피부 물어뜯기
 - 머리흔들기: 6~12개월 신생아에서 시작됨
 - 손톱 물어뜯기: 1세에서 시작해서 12세에서도 시작됨. 아동이 불안하거나 스트레스 받았을 때 나타나거나, 강도가 증가함.
- 일시적으로 2~4세 아동 60%에서 나타남
 - 2세에서 가장 다발 / 나이들수록 감소 / 6세 유병률 15~20%
- 남아 > 여아
- 자폐, 지적장애 아동에서 반복적인 정형적 행동증상이 자주 나타남

감별	틱장애	혼자있을 때 증상이 더 많으며 아이에게 스트레스를 줌
	상동증적 운동	틱장애에 비해 병정기간이 더 길고, 더 리듬감 있음 균일한 빈도로 나타나며 아이에게 안정감을 줌

틱장애 ②

교과서	DSM-4 유아청소년기에 처음 진단되는 장애	DSM-5 신경발달적 장애
5) 소아기 및 청소년기 발병의 사회성 기능장애 6) 틱장애	• 틱장애 -뚜렛장애 -만성운동 또는 음성 틱장애 -일과성 틱장애 (transient) -틱장애 NOS	• 운동 장애 -발달성 운동 조정장애 -상동증적 운동장애 -틱장애 :뚜렛장애 :만성운동 또는 음성 틱장애 :일시적 틱장애 (provisional)

틱장애는 DSM4에서는 운동장애와 별개의 항목이었는데, DSM5에서는 운동장애의 종류로 들어감

DSM 4: 일과성 틱장애 transient Tic disorder -> DSM 5: 일시적(잠정적) 틱장애 provisional tic disorder

일과성 transient: 한번 나타나고 사라지는 것

<-> 일시적 provisional: 한번 지나갔어도, 다시 나타날 수 있음(확정되지 않음)

틱장애는 성인기가 되어야 안정되기 때문에 성인기가 되고 나서야 그게 일회성이었구나~ 하고 알 수 있음.

재발하게 되면: 이전에 보였던 증상보다 길어지고 심해지고 악화됨

틱의 정의

✓ 갑작스럽고 빠르게 반복적이고 상동적인 근육의 움직임 또는 소리

	운동틱(motor tic)	음성틱(vocal tic)
단순	눈깜박임, 눈알 움직임, 얼굴 찡그림, 머리 흔들기 등	가래뱉는 소리, 킁킁거림, 기침소리, 침 뱉는소리 등(특정한 소리나 음성을 반복)
복합	자신을 치는 행동, 갑자기 뛰어오르는 행동, 의미없이 물건을 만지는 행동 등	상황과 전혀 관계없는 단어나 구절 등 반복 ('옳다', '입닥쳐' 등), 반향어 등(어절, 단어, 문장의 형태로 반복)

증상

(1) 초기 증상

- 단순 근육틱이 80%, 음성틱은 20%이하
- 단순 근육틱 중 눈 깜박임을 포함한 얼굴 근육틱이 70%

(2) 전조 감각 충동

- 10세, 11세 아동들에게 틱에 선행하여 나타나며 틱이 나타나면 사라지는 전조증상을 희미하게 인식함
- 짝 조이는 느낌, 민감도 증가, 몸의 어느 특정부위에 달아오르는 듯한 불편감 전신적인 긴장감, 등

틱은 완벽한 불수의적인 운동이라 해석하기 어렵고 불편감을 해소하기 위한 행동으로 해석!
단순틱은 신체적 불편감이 있어 해소하는 것, 복합틱은 심리적인, 감각적인 충동을 포함.

(3) 틱은 1초 이상 지속되는 경우가 드물고, 한꺼번에 삽화적으로 발생하는 경향

잠정적(일시성) 틱장애 Provisional Tic Disorder

A. 한가지 또는 다수의 운동틱 또는 음성 틱이 존재한다.

운동틱과 음성틱 중 하나만 나타난다.

B. 틱은 처음 틱이 나타난 시점으로부터 1년 미만으로 나타난다.

C. 18세 이전에 발병한다.

D. 장애는 물질(예; 코카인)의 생리적 효과나 다른 의학적 상태(예; 헌팅턴병, 바이러스성 뇌염)로 인한 것이 아니다.

E. 뚜렛장애나 지속성(만성) 운동 또는 음성 틱장애이 진단기준에 맞지 않아야 한다.

#지속성(만성) 운동 또는 음성 틱장애

Chronic Motor or Vocal Tic Disorder

A. 한가지 또는 여러 가지 운동틱 또는 음성틱이 장애의 경과 중 일부 기간 동안 존재하지만, 운동틱과 음성틱이 모두 나타나지는 않는다.

B. 틱 증상은 자주 악화와 완화를 반복하지만 처음 틱이 나타난 시점으로부터 1년 이상 지속된다.

C. 18세 이전에 발병한다.

D. 장애는 물질(예;코카인)의 생리적 효과나 다른 의학적 상태(예; 헌팅턴병, 바이러스성 뇌염)로 인한 것이 아니다.

E. 뚜렛장애의 진단기준에 맞지 않아야한다.

뚜렛 장애 Tourette's Disorder

A. 여러 가지 운동틱과 한가지 또는 그 이상의 음성틱이 질병 경과 중 일부 기간 동안 나타난다. 2가지 틱이 반드시 동시에 나타날 필요는 없다.

B. 틱 증상은 자주 악화와 완화를 반복하지만 처음 틱이 나타난 시점으로부터 1년 이상 지속된다.

C. 18세 이전에 발병한다.

D. 장애는 물질(예;코카인)의 생리적 효과나 다른 의학적 상태(예; 헌팅턴병, 바이러스성 뇌염)로 인한 것이 아니다.

틱장애의 원인

- 심리적 요인: 불안 관련
- 악화요인: 신학기, 가정불화, 학업 스트레스, 지나친 컴퓨터 사용
- 기질적 요인: 유전적인 요인이 관련

유병율과 예후

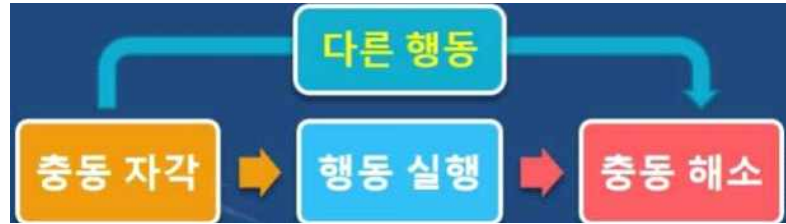
- 유병율 약 4%
- 여 : 남 = [틱장애] 1 : 1.5~2 / [뚜렛장애] 1 : 3
- 발병연령: 2~15세 사이, **5~7세에 가장 흔하게 발병**
- **대개 단순 운동틱으로 시작하여 복합 운동틱으로 진행**
얼굴에서 시작해서 목, 아래, 팔 등 아래로 내려감
- 음성틱은 대개 운동틱보다 3~4년 늦게 나타나는 경향
- 증상은 시간이나 상황에 따라 변화하며, 스트레스를 받으면 일시적으로 악화
- 치료되지 않는 경우 만성경과를 가지며 평생동안 지속될 수 있음
- ADHD, 강박장애가 동반되거나, 조기 발병의 경우 예후가 나쁨

동반이환

ADHD	뚜렛장애로 병원에 내원한 임상군에서는 40-50%, 지역사회 뚜렛환자 군에서는 8~27%의 아동에서 ADHD 공존함.	
OCD (Obsessive-Compulsive Disorder, 강박장애)	틱 연관 강박	• 사춘기 이전 발병 • 호전적이며 성적인 내용이 혼합된 강박사고 多 • 남아에게 多 • 좌우대칭과 정확성에 대한 걱정을 함
	틱 무관 강박	• 사춘기 무렵이나 사춘기 이후 발병 • 남녀비슷 • 주로 오염에 대한 걱정과 씻는 강박행동

치료

- 사회적, 학업적 기능에 문제 없는 가벼운 틱은 치료 필요 X
- 틱으로 인해 유발된 사회·정서적 문제, 우울, 고립, 따돌림을 고려
- 머리와 목 부위의 틱은 두통, 편두통을 악화시킬 수 있음
- **일과성 틱장애는 극심한 경우가 아니라면 약물치료보다 부모교육 우선**
아동의 틱 증상에 대해 너무 예민하게 반응하지 않도록 함
가족들이 아동의 틱 증상에 대하여 무관심한 것이 좋음

행동 및 심리사회적 치료	• 목표 : 틱장애 자체 치료 X, 틱조절 기술 O • 습관 뒤집기 훈련(습관반전법) - <u>자각훈련</u>: 환자가 틱이 일어난 때나 틱이 일어날 것에 대하여 자각할 수 있게 하기 - <u>경쟁반응 훈련</u>: 틱과 신체적으로 양립할 수 없는 행동을 하도록 환자를 교육하기 - 이완훈련 
약물 치료	• Risperidone 비정형 조현병 치료제 - 가장 효과적이라고 밝혀졌으며, 부작용 적은 편 - 흔한 부작용: 체중증가, 대사질환, 고프로락틴혈증 - pimozide에 비해 risperidone이 틱증상 뿐 아니라 공존하는 OCD 증상 감소에도 더욱 효과적임 • Haloperidol, Pimozide(도파민 억제제) - 뚜렛장애에 사용 승인 - 추체외로계 부작용의 위험성. 사용이 추천되지 않음

4절. 의사소통장애 Communication Disorders

교과서	DSM-4 유아청소년기에 처음 진단되는 장애	DSM-5 신경발달적 장애
1. 정신적 발달장애 1) 말과 언어의 특수 발달장애 (1) 특수 조음장애 (2) 표현성 언어장애 (3) 수용성 언어장애 (4) 간질을 연합한 후천성 실어증 (란다우-클레프너 증후군)	의사소통 장애 • 표현형 언어장애 • 복합 수용성 언어장애 • 말소리 장애 • 말더듬기 장애 • 상세불명의 의사소통 장애	의사소통 장애 • 언어 장애 • 말소리 장애 (=발화음장애) • 아동기-발생 유창성 장애(말더듬기) • 사회적 의사소통 장애

개요

: 지능은 정상이나 말이나 언어의 결함이 있는 장애

언어장애 ①	이해력이나 표현력의 결함 때문에 언어의 습득과 사용에 지속적인 곤란
발화음장애 ②	= 발음장애, 발성장애, 구음장애, 음성학적 장애 발음의 지속적인 곤란 때문에 언어적 의사소통에 지장
아동기-발생 유창성장애(말더듬기) ③	말을 더듬어 언어의 유창성에 지장
사회적 의사소통 장애 ④	언어적/비언어적 의사소통 기술의 사회적 사용에 지속적 인 곤란

언어장애① & 말소리 장애②

- ✓ 언어장애: 어휘, 문장구조, 담론에 대한 이해(수용언어)와 생성(표현언어)의 결함으로 **언어의 습득과 사용**에 어려움을 겪는 것.
 - 어휘: 단어에 대한 지식과 사용
 - 문장구조 : 문법이나 형태론적 법칙을 기초로 단어와 어미를 배치하여 문장을 만드는 능력
 - 담화: 주제나 일련의 시간을 설명하거나 기술하고 대화를 나누기 위한 어휘사용, 문장 연결 능력
- ✓ 말소리장애: **말소리를 내는 것**에 지속적인 어려움을 겪음
 - *말소리 내기: 음소(개별적 소리)를 또렷이 소리내어 구어를 조합하는 것
 - 조음 음운장애: 잘못되거나 미숙한 발음이 시기가 지났는데도 계속됨
 - 말더듬(유창성 장애): 말이 정상적으로 자주 끊어지거나 말속도가 불규칙하거나 말을 할 때 불필요한 노력이 들어가는 것
- ✓ 감별진단(지적장애): **언어지연은 지적장애에서 흔히 나타남.**
언어결함이 지적 한계의 정도를 명백히 초과하지 않는 한 별도의 진단을 내리지 않음

	언어장애 ①	말소리장애 ②
DSM-4	- 혼재 수용-표현 언어장애 - 표현언어장애	- 음운장애 - 말더듬
ICD-10	- 수용언어장애 - 표현언어지체 - 간질을 동반한 실어증	특정조음장애
언어치료 임상	- 언어발달장애 - 언어발달지체 - 언어표현지체 - 단순언어장애 - 실어증	- 조음/음운장애 - 유창성장애 - 음성장애

표 24-2. 언어문제를 일으키는 장애들의 감별적 특성

	청력장애	정신지체	유아자폐증	표현성 언어장애	수용성·표현성혼합 언어장애	선택적 함구증
언어의 이해	-	-	-	+	-	+
언어의 표현	-	-	-	-	-	제한됨
청력	-	+	+	+	다양함	+
발음	-	-	다양함	다양함	다양함	+
내적 언어 internal language	+	제한됨	-	+	제한됨	+
몸짓상태	+	제한됨	-	+	+	+
따라하기	-	+	제한됨	+	+	+
소리에 대한 주의	제한됨	+	-	+	다양함	+
얼굴 쳐다보기	+	+	-	+	+	+
동작성 기능	+	-	다양함	+	+	+

* Cited from Psychiatric and developmental disorders in children with communication disorder (by Cantwell and Baker) and 최신정신의학(민정길 저), + 정상; - 비정상

빨간 네모 박스 내용만 읽으심 4 50

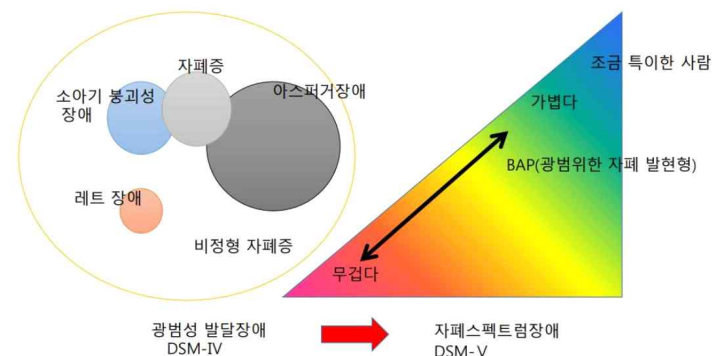
사회적 의사소통 장애 ④

- DSM-5에서 추가된 장애
- 언어적, 비언어적 의사소통 기술의 사회적 사용에 지속적인 어려움을 겪는 경우
- 의사소통 기술의 사회적 활용 - 아래 4가지 모두에 어려움을 나타내어 사회적 적응에 현저한 지장이 초래되는 경우 진단
 - 인사하기나 정보 교환과 같은 사회적 목적을 위해 맥락에 적절하게 의사소통
 - 맥락이나 듣는 사람의 필요에 맞추어 의사소통을 적절히 변화시키기 (ex. 놀이와 교실, 아이와 어른)
 - 대화과 이야기하기에서 규칙을 따르기 (ex. 번갈아 말하기, 이해하지 못했을 때 되묻기)
 - 명시적으로 표현되지 않은 것이나 언어의 함축적, 이중적 의미 이해하기
- 반복적 상동패턴이 없어도 자폐진단이 내려지는 것을 방지하기 위한 분류

	사회적 의사소통 장애	자폐 스펙트럼 장애
반복적 상동패턴	X	O

5절. 전반적 발달 장애 Pervasive Developmental Disorders = 자폐스펙트럼 장애 Autism Spectrum Disorder (ASD)

교과서	DSM-4 유아청소년기에 처음 진단되는 장애	DSM-5 신경발달적 장애
광범위성 발달장애 (1) 소아기 자폐증 (2) 비전형적 자폐증 (3) 레트 증후군 (4) 소아기의 기타 붕괴 성 장애 (5) 아스퍼거 증후군	광범위성 발달장애 ① • 자폐 장애 • 아스퍼거 장애 ② • 레트 장애 ③ • 소아기 붕괴성 장애 ④ • 상세불명의 광범위한 발달장애	• 자폐 스펙트럼 장애 ②
- 자폐 스펙트럼 장애(ASD)로 명칭 변경 → DSM-4의 자폐증, 아스퍼거 장애, 소아기 붕괴성 장애, 상세불명의 광범위한 발달장애를 포함하는 개념 - 차원적 접근을 시도 → 아스퍼거 장애가 자폐스펙트럼으로 통합 - 레트장애 삭제 - 진단 기준이 엄격해짐 → 자폐장애 감별 민감도 ↑, 유병율 ↓ - 사회적 의사소통에 뚜렷한 결함이 있으나 자폐스펙트럼 장애의 다른 진단 항목을 만족하지 않는 경우 Social(=Pragmatic) Communication Disorder 사회적 의사소통장애라는 새로운 진단으로 진단함. 3세 이전 발병기준이 early childhood로 완화됨		



DSM-4 vs DSM-5

DSM-IV-TR 자폐장애 진단기준

A. (1), (2), (3)에서 총 6개(또는 그 이상), (1)에서 최소 2개, (2)와 (3)에서 각각 1개 항목이 충족된다:

(1) **사회적 상호 작용에서의 질적인 장애가 다음 중 적어도 2개 항목으로 나타난다:**

(a) 사회적 상호 작용을 조절하기 위한 눈 맞춤, 얼굴 표정, 몸 자세, 몸짓과 같은 다양한 비언어적 행동을 사용함에 있어서 현저한 장애

(b) 발달 수준에 적합한 동료 관계 발달의 실패

(c) 자발적으로 다른 사람들과 즐거움, 관심, 성취감을 나누지 못함(예: 관심의 대상을 보여주거나, 가져오거나, 지적하지 못함).

(d) 사회적, 감정적인 상호 작용의 결여

(2) **의사소통의 질적인 장애는 다음 항목들 가운데 적어도 1개 항목으로 나타난다:**

(a) 구두 언어 발달의 지연 또는 완전한 발달 결여(몸짓이나 흉내내기와 같은 의사소통의 다른 방법으로 보충하려 하지 않는다)

(b) 사람과 적절하게 대화를 하는 데 있어서, 대화를 시작하거나 지속하는 능력의 현저한 장애

(c) 상동적이고 반복적인 언어나 괴상한 언어의 사용

(d) 발달 단계에 적합한, 자발적이고 다양한 가상적 놀이나 사회적 상징 놀이의 결여

(3) **제한적이고 반복적이며 상동적인 행동이나 관심, 활동이 다음 항목들 가운데 적어도 1개 항목으로 표현된다:**

(a) 한 가지 이상의 상동적이고 제한적인 관심에 몰두하는데, 강도나 집중하는 정도가 비정상적으로 집착함

(b) 특이하고 비효율적인, 틀에 박힌 일이나 의식에 완고하게 집착함

(c) 상동적이고 반복적인 동작성 매너리즘(예: 손 또는 손가락으로 퍼덕이거나 돌리기, 또는 복잡한 몸 전체 움직임)

(d) 대상의 부분에 지속적으로 몰두

B. 다음 영역 가운데 적어도 한 가지 영역에서 기능이 지연되거나 비정상적이며, **3세 이전에 시작된다:**

(1) 사회적 상호 작용

(2) 사회적인 의사소통에서 사용되는 언어

(3) 상징적 또는 가상 놀이.

C. 장애가 레트 장애 또는 소아기 붕괴성 장애로 더 잘 설명되지 않는다.

DSM-5 자폐스펙트럼 장애 진단기준

A. 다양한 분야에 걸쳐 나타나는 **사회적 의사소통 및 사회적 상호작용의 지속적인 결함**으로 현재 또는 과거력상 다음과 같은 특징으로 나타난다.

(1) 사회적-감정적 상호성의 결함에 비정상적인 사회적 접근과 정상적인 대화의 실패, 흥미나 감정 공유의 감소, 사회적 상호작용의 시작 및 반응의 실패

(2) 사회적 상호작용을 위한 비언어적인 의사소통 행동의 결함(예 언어적, 비언어적 의사소통의 불완전한 통합, 비정상적인 눈 맞춤과 몸짓 언어, 물건의 이해와 사용의 결함, 얼굴 표정과 비언어적 의사소통의 전반적 결함)

(3) 관계발전, 유지 및 관계에 대한 이해의 결함(예 다양한 사회적 상황에 적합한 적응적 행동의 어려움, 상상 놀이를 공유하거나 친구 사귀기가 어려움, 동료들에 대한 관심 결여)

B. **제한적이고 반복적인 행동이나 흥미, 활동이 현재 또는 과거력상 다음 항목들 가운데 적어도 2가지 이상** 나타난다.

(1) 상동증적이거나 반복적인 운동성 동작, 물건사용 또는 말하기(예 단순운동 상동증, 장난감 정렬하기, 물체 빙기기, 반향어, 특이한 문구 사용)

(2) 동일성에 대한 고집, 일상적인 것에 대한 융통성 없는 집착, 또는 의례적인 언어나 비언어적 행동 양상(예 작은 변화에 대한 극심한 고통, 변화의 어려움, 완고한 사고방식, 의례적인 인사, 같은 길로만 다니기, 매일 같은 음식 먹기)

(3) 강도나 초점에 있어서 비정상적으로 극도로 제한되고 고정된 흥미(예 특이한 물체에 대한 강한 애착 또는 집착, 과도하게 국한되거나 고정스러운 흥미)

(4) 감각 정보에 대한 과잉 또는 과소 반응, 또는 환경의 감각 영역에 대한 특이한 관심(예 통증/온도에 대한 명백한 무관심, 특정 소리나 감촉에 대한 부정적 반응, 과도한 냄새 맡기 또는 물체 만지기, 빛이나 움직임에 대한 시각적 매료)

C. 증상은 **반드시 초기 발달 시기부터 나타나야 한다**(그러나 사회적 요구가 개인의 제한된 능력을 넘어서기 전까지는 증상이 완전히 나타나지 않을 수 있고 나중에는 학습된 전략에 의해 증상이 감춰질 수 있다)

D. 이러한 증상은 사회적, 직업적 또는 다른 중요한 현재의 기능 영역에 임상적으로 뚜렷한 손상을 초래한다.

E. 이러한 장애는 **지적장애(지적발달장애)** 또는 **전반적 발달지연**으로 더 잘 설명되지 않는다.

↑ 빨간색 글씨만 읽으심!

- ✓ DSM-5의 자폐스펙트럼 장애는 아스퍼거 증후군을 포함하기 때문에 ‘**의사소통의 질적인 장애**’ 항목이 없음
- ✓ DSM-4-TR 자폐장애진단기준에서는 3세 이전에 시작되는 것으로 명시함
- ✓ 지적장애와 자폐스펙트럼장애는 자주 동반된다. 자폐스펙트럼장애와 지적장애를 함께 진단하기 위해서는 **사회적 의사소통이 전반적인 발달수준에 기대되는 것보다 저하되어야 한다.**

광범위성 발달장애 Pervasive Developmental Disorders ①

[DSM4, 교과서, 참고]

- 소아기에 사회적 상호작용, 의사소통, 또는 상동적 행동, 흥미, 활동, 지각장애 등 여러분야의 발달이 심각하게 전반적으로 손상

Autistic Disorder 자폐성 장애	3세 이전 발생
Rett's Disorder 레트장애	생후 6개월 이후 심각한 발달, 성장장애
Childhood Disintegrative Disorder 소아기 붕괴성 장애	생후 2-3년간 정상적 발달 3-4세부터 수개월간에 걸쳐 지적/사회적/언어 기능 붕괴
Asperger's Disorder 아스퍼거 증후군	사회적 상호작용 어렵고 언어발달 지연은 없음
Pervasive Developmental Disorder NOS 기타 광범위성 발달장애	

자폐스펙트럼 장애 Autism Spectrum Disorder ②

역학

- 아동 만명당 2~5명, 여아보다 남아의 출현율이 높음
- 일부 연구에서는 여자 환자의 경우 남자보다 증상이 훨씬 심한 것으로 보고됨

임상특징

① 사회적 행동의 결손

영아기	• 눈맞춤을 피하고 / 사람의 말소리에 거의 관심을 보이지 않고 / 안기려고 팔을 내밀지 않으며 / 감정이 무디고 / 표정도 거의 없음
유아기	• 눈맞춤은 계속 피하지만 신체적 접촉을 수동적으로 받아들임 (ex. 간지르는 것을 즐기거나 무릎에 앉는 것) • 그러나 애착행동을 보이지 않고 유대감을 형성하지 못함 • 대다수의 자폐아가 격리 불안이나 낯선 이에 대한 불안을 보이지 않아 낯선 사람에게도 부모처럼 쉽게 접근하지만 • 다른 아동들과 함께 노는데 흥미를 보이지 않으며 적극적으로 피하기도 함
아동 중기	• 부모나 친숙한 성인에게 애착을 보이긴 하나 집단게임에는 관심을 보이지 않고 또래들과 관계를 맺을 수 없는 심각한 사회적 어려움 • 나이가 들며 부모형제들에게는 애정을 보이고 다정하게 대함

② 의사소통문제 (DSM-4)

(1) 비언어적 의사소통에서의 손상

영아기	• 울거나 소리지르는 것으로 욕구를 나타냄
유아기	• 원하는 것을 얻기 위해 성인의 손을 끌거나 구체적인 몸짓을 사용하나, 적절한 표정이 수반되지는 않음 • 말과 함께, 혹은 말의 대체로써 고개를 끄덕이거나 옆으로 흔드는 일이 거의 없고 모방을 잘 하지 않음

- 일반적으로 자폐아는 기쁨, 두려움, 분노의 감정을 나타내 보일 수 있으나 **극단적**으로만 표현

(2) 구어 이해의 손상

- 구어 이해의 손상 정도는 장애 정도에 따라 다양함
- 장애가 다소 덜 심한 자폐아는 상황에 맞는 간단한 지시를 내리거나 몸짓과 함께 지시를 내리면 따를 수 있음.
- 영리한 자폐인도 유머나 관용적인 표현에는 혼란스러워 함.

(3) 구어발달의 손상

- 자폐인의 절반 정도는 평생 구어를 사용하지 못하며 말을 하는 경우에도 **반향어**나 대명사 정도 보임.
- 로봇이 말하는 것과 유사함. **높낮이, 억양, 속도, 리듬 등이 비정상적.**
- 일부 자폐아는 자기 자극적인 목적으로 아무 의미없는 단어나 구절을 반복
- 말을 자발적으로 하는 자폐인도 말의 문법적인 구성이 미성숙하여, 전치사, 접속사, 대명사를 빼거나 잘못 사용하기도 함
- 말을 잘하는 자폐인도 상호 교류적 대화보단 **일방적으로** 말을 한다는 느낌을 줌
+대화를 시작하거나 지속하는 것이 어렵고, 표정이나 몸짓이 경직되어 있다. + 반향어

③ 비정상적인 행동패턴

(1) 변화에 대한 저항	• 친숙한 환경에 어떤 변화가 일어나면 행동문제를 보임 • 많은 자폐아가 장난감이나 물건을 일렬로 세우는 행동을 보이는데 이를 방해하면 심한 스트레스를 받음.
(2) 의례적이고 강박적인 행동	• 어떤 절차를 엄격하게 지킴 (ex.특정음식만 먹음) (방에 들어가기전 특정한 행동을 하는 우영우, 김밥만 먹는 우영우) • 상동적이고 반복적인 움직임 (ex. 박수, 손가락 꼬기)
(3) 비정상적인 대물애착	• 이상한 물건에 강한 애착 (고래를 좋아하는 우영우) • 그 물건을 항상 가지고 다니며 빼앗으면 저항, 짜증
(4) 감각경험에 대한 비정상적 반응	• 빛, 무늬, 소리, 회전물체, 촉각적 감각에 사로잡히기도 • 감각적인 자극에 대해서 과소 혹은 과잉반응

④ 운동성 장애

- 전형적인 운동발달은 지체되지만 종종 정상범위내에 속함.
- 동작모방에 어려움을 보임

⑤ 지능과 인지적 결손

- 대다수의 자폐아는 지적장애아
→ 40~60%는 IQ 50이하이며, 단지 20~30%만이 IQ 70이상임
- IQ가 낮은 자폐아가 더 예후가 불량함
- 시공간기술 혹은 단기기억에서는 우월하지만, 상징적이거나 추상적인 사고나 순열적인 논리에서는 열등함

평가

- 자폐장애는 유전·선천·환경적 요소가 어느정도 관여하든지 근본적으로 신경생물학적 이상에 기인함
- 과거력
- 발달력
-일반적인 발달이정표
-언어 / 사회성 / 놀이 측면에서 평가
- 아동관찰 및 면담, 인지평가
- 의학적 평가 및 조사 : 치료할 수 있거나 자폐증처럼 보이는 증상을 나타내는 의학적 상태나, 유전될 수 있는 fragile X syndrome이나 tuberous sclerosis처럼 가족에게 중요한 의학적 상태를 찾아내기 위함.

공병

- 지적장애
-자폐증 67-88%는 지적장애를 보임
-예후는 지능·언어발달에 따라 상이, 언어능력은 전체적으로 지능과 밀접히 연관
- 간질
-일부 자폐아에서는 일찍이 경련발작이 일어남
-모든 자폐아의 1/3에서 경련이 일어남

- 지적장애가 같이 있는 경우가 더 흔함.

- 시력 또는 청력 손상: 청력상실이 시력상실보다 더 관련
- 기타 동반되는 정신과 장애
- 많은 자폐인이 자폐증의 핵심 증상 외에 다른 행동적, 정신과적인 증상을 보임
- 낮은 주의집중, 과다 활동, 비정상적인 몰입, 강박적인 현상, 상동행동, 불안이나 공포, 우울한 기분, 짜증, 부적절한 감정상태, 수면문제, 자해행위, 틱 장애

감별진단

1) 현재 지능수준 결정

2) 언어 발달과 지능이 평행을 이루고 있는가를 봐야함

-지적 장애아에서 언어가 다소 정신연령에 뒤지는 것은 흔함. 언어수준이 정신연령에 적어도 일년이상 뒤지지 않는 한 언어지연으로 진단내려서는 안됨.

3) 아동의 행동이 실제연령, 정신연령, 언어 연령에 적합한가를 봐야함

- 아동의 행동이 나머지 발달과 맞는다면 자폐증이라 진단내릴 수 없음

4) 언제라도 정상발달의 시기가 있었는지 확인해야함

- 두 살에서 두 살반까지 정상발달을 보였다면 선택적 함구증이나 와해성 장애를 고려해야함.

발달성 언어장애	• 발달성 언어장애 아동은 5세 이전에 자폐와 유사한 특성을 보일 수 있음 • 자폐와 달리 감정과잉·과소반응 X • 자폐에 비해 비언어적 몸짓, 표정으로 타인과 관계 가능
지적장애	• 지적장애를 동반하는 자폐아가 더 많음 • 때때로 경계가 매우 불분명
정서박탈 <i>질환보다는 정서적 욕구가 충족되지 못해 일시적으로 생기는 형태</i>	• 여러사람이 아이를 돌보는 시설에서 자란 지진아는 자폐아와 비슷한 대인관계, 언어, 행동이상을 보임 • (감별점): 애착을 구하고 정상적 관계의 오고감이 가능하고, 의사소통을 위해 언어를 사용함 • 긍정적인 환경의 자극에 의해 빠르고 지속적인 발달을 보임

치료

- **목적: 자폐아의 사회적 언어 발달을 촉진시키고 부적응 행동을 최소화**
 - 가능한한 조기에 발견하여 치료시작
 - 발달 전체를 도와주는 다각적이고 다학적인 접근방법
 - 부모를 통한 치료나 교육이 중요함.
- **호전에 대한 장애물이 되는 자폐아동의 특징**
 - 최소한의 협력이 부족: 치료자에게 무감각하고 저항적
 - 치료과정에서 오는 변화에 저항적
 - 일반화, 내재화의 어려움: 가르쳐 준 것만 배운다. 자극과 보상이 지속적으로 필요
 - 주도성 결여: 스스로 연습, 습득하려는 동기의 부족

응용행동분석(행동수정)	• 자폐아동의 행동과 주변 환경을 철저히 조직화, 분석해서 자폐적 행동 발생을 차단하고 바른 반응을 할 수있도록 교육시키는 방법 - 스스로를 돌볼 수 있는 기술, 의사소통 기술, 놀이기술을 증가시켜주고, 공격성을 감소
TEACCH 프로그램 (티치 프로그램)	• 강점 위주의 접근. 시각에 우위-> 해야할 것을 시각적으로 보여줌 반복적이고 규칙적인 것을 잘 따라함 • 개인간 차이나 개인내 차이를 기초로 하는 발달적 접근으로 개인의 평가에 기초 • 가족의 중요성 강조, 공동치료자로서의 부모 강조 • 환경 구조화 강조: 자폐아동은 구조화되고 규칙성 있는 예언적 환경에서는 잘 적응함 • 다양한 의사소통방법 활용: 자폐아동의 언어 능력의 결함을 보완(시각적 우위, 동일성 추구)
사회적 상호작용 발달치료 접근모델 (DIR모델)	• 발달의 초기 단계에 일어나는 사회적 상호작용능력의 결함에 초점 • 부모와 자폐아동간의 관계, 사회적 상호작용 발달 강조

	• 근접성 유지, 친밀한 신체접촉, 눈맞춤, 모방, 사회적으로 적절한 행동에 대한 민감성, 공감적 주의 등
약물치료	• 자폐증의 경로를 바꾸지는 못하지만 • 과잉운동, 위축, 상동증, 자해행동, 공격성, 수면장애 같은 특정증상을 통제하는데 도움이 됨

경과와 예후

- **만성적인** 예후를 보임

청소년기	• 청소년기에 지적 능력의 감소 같은 진행성 퇴행을 보이는 경우는 소수임 • 신경학적 장애의 임상적 증거를 보이지 않던 자폐아의 7~28%가 청소년기나 성인 초기에 첫 경련 • 과잉행동은 과소행동과 동기부족으로 대체되며, 일부는 전보다 더 많은 불안과 긴장을 보이기도 함 • 부적절한 성적 호기심으로 인해 신체 노출이나 자위행위 같은 행동을 보이기도 함.
성인기	• 성공적인 자폐인들도 일상생활에 있어서 공감능력이나 사회적인 상황에 있어서의 적절한 처신이 결여됨 • 지적장애 아동은 자기들의 지능보다 오히려 높은 수준의 능력을 보이는 것과 대조적으로 자폐아동은 자조능력, 일상생활을 영위하는 기술이 지능수준보다 오히려 낮음.

- **5~17%**의 자폐아가 전반적인 사회적 적응에서 좋은 결과
- **2/3**은 심하나 장애로 인해 어떤 독립적인 생활도 영위 불가능
- 39~74%가 시설에 수용되며 나이가 들수록 수용인원 증가
- **IQ**가 가장 예후를 잘 예언해줌.

아스퍼거 증후군 Asperger's Disorder [DSM-4] ㉔

- 제한되고 반복적인 행동과 관심(내용은 적절할 수 있으나 그 강도가 이상한 특이한 관심)
- 사회적 상호작용 손상
- **언어 인지적 기능과 적응행동(사회적 상호교류 이외의)에서 정상범주**
- 공병: 뚜렛장애, 강박장애
- 감별진단

자폐장애	• ICD-10 정의는 언어발달 지연의 부재를 강조하고 있음
강박장애	• 반복행동과 상동증 유형을 공유 • BUT 강박장애와 대조적으로 아스퍼거 장애는 사회적 상호작용의 손상, 관심과 활동이 더 제한적

DSM-4 진단기준

A. **사회적 상호작용의 질적인 장애**로 다음 중 최소 2개가 나타난다.

- (1) 다양한 비언어성 행동 즉 사회적 상호교류를 통제하는 눈과 눈으로 쳐다보기(eye-to-eye gaze), 얼굴표정, 몸짓 및 제스처를 보이는데 현저한 지장이 있다.
- (2) 발달수준에 적합한 친구관계를 형성하지 못한다.
- (3) 다른 사람의 행동을 기뻐해주는 표현법에 현저한 지장이 있다.
- (4) 사회적 또는 정서적 상호교환이 부족하다.

B. **행동, 관심 및 활동이 한정되고, 반복적이고 상동적인 양상**으로 다음 중 최소 1개로 나타난다.

- (1) 하나나 그 이상의 상동적이고 한정된 관심에 몰두하는데 그 강도나 또는 집중 정도가 비정상이다.
- (2) 외관상 독특하고 비기능적인 일상의 일 또는 관습에 변함없이 집착한다.
- (3) 상동적이고 반복적인 운동현기증(motor mannerism)(예: 손 또는 손가락 부딪치거나 비꼬기, 또는 복잡한 전신의 움직임)
- (4) 물체의 한 부분에 지속적으로 집착한다.

C. 본 장애는 사회, 직업 또는 다른 중요한 분야의 기능에 임상적으로 현저한 지장을 초래한다.

D. **임상적으로 현저한 일반적 언어발달의 지연이 없다**(예: 2세까지 한 단어를 말하고, 3세까지 구를 사용하여 의사소통을 한다.)

E. **인지발달 또는 나이에 적합한 자립능력발달, 적응행동(사회적 상호교류 이외의) 및 소아기에서 보는 환경에 대한 호기심발달이 임상적으로 현저한 지연을 보이지 않는다.**

F. 진단기준이 다른 특정한 전반적 발달장애 또는 정신분열병 기준에 맞지 않는다.

↑ D, E만 읽으실

레트장애 Rett Disorder [DSM-4] ㉕

- 적어도 **생후 5개월까지는 정상적으로 발달**하다가 **그 후 (5~48개월 사이에) 과거에 배운 기술을 상실하는 것**
- 머리의 성장 감소, 목적이 있는 손 움직임을 상실, 상동적인 움직임
- 사회적 관계 상실 / 협응되지 않는 걸음 / 심한 정도의 지적장애 수반
- **여아에서만**
- CDC-IRSA 필요한 기준

- 정상적 산전, 주산기
- 생후 첫 6개월간의 정상적 정신운동 발달
- 출산시의 정상적 머리둘레
- 5개월과 4세 사이의 머리 성장 감소
- 6개월에서 30개월 사이의 목적 있는 손기술의 상실
- 손을 쥐어 짜기, 씻기, 탁탁 치기 입에 손을 가져가는 행동등 상동증적 손움직임
- 표현 수용 언어의 심각한 손상
- 심한 정신운동 둔마
- 1~4세 사이의 보행실행증, 체간실행-실조증
- 일시적 사회적 위축
- 진단은 2~5세까지는 시험적임.

최근 유전자 돌연변이에 의해 나타난다는 것이 알려짐 -> 신경계 질환이니 DSM 5에서 삭제

- 진행성 신경학적 장애
- 갑자기 예기치 않은 사망이 흔함
(뇌간기능 부전의 결과로 인한 호흡정지, Q-T간격의 증가, T파이상등의 심장이상)
- 대부분 40대까지 산다.
- Hagberg, Wit-Engerstrom(1990) 4단계 모델

6개월~1세반	초기 발병 침체시기
1~2세	발달상 빠르게 퇴행하는 시기
3~4세	가성 안정시기, 지연될 수 있고 수십년까지 지속될 수도
학령기, 청소년기	늦은 운동 황폐시기

소아기 붕괴성 장애 Childhood Disintegrative Disorder [DSM-4] ©

- 적어도 **2년간의 정상발달기간 후에** 자폐적 상태가 나타나는 경우
- [수용적 또는 표현적 언어 / 사회적 기술이나 적응적 행동 / 대소변 가리기 / 놀이 / 운동기술]의 5개 영역 중 적어도 2가지 이상의 분야에서 **10세 이전에 학습한 능력을 의미있는 수준으로 상실**하는 경우
- 3,4세까지 정상발달을 보임
- 몇달을 경과하며 언어를 완전히 잃게 됨
- 인지능력은 물론 언어 이해의 소멸이 있음
- 사회성 기술과 대인관계가 손상되며 환경에 관심이 없어짐
- 안전부절, 상동적 반복행동, 얼굴 찡그림과 같은 매너리즘과 턱이 생김
- 남아 : 여아 = 5.5 : 1
- **약 75% 이상이 중증 또는 극심한 지적장애 상태 유지**
- 자폐증에 비해 낮은 기능을 보이고, 더 많은 간질을 동반하며, 더 무관심함
- 15%가 사망

DSM-4 진단기준

- A. 생후 적어도 **2년 동안 분명한 정상발달**이 이루어지는데 이는 나이에 적절한 언어적, 비언어적 의사소통, 사회관계, 놀이, 적응행동으로 드러난다.
- B. 다음 영역 가운데 적어도 2개 영역에서 **과거에(10세 이전에)습득했던 기술이 임상적으로 심각한 수준에서 상실**된다.
- (1) 표현성 언어 또는 수용성 언어
 - (2) 사회적 기술 또는 적응행동
 - (3) 대변 또는 방광 조절
 - (4) 놀이
 - (5) 운동성 기술
- C. 다음 영역 가운데 적어도 2개 영역에서 기능장애:
- (1) **사회적 상호작용에서의 질적인 장애**(예: 비언어적 행동장애, 친구관계의 발달 실패, 사회적 또는 감정적 상호교육의 결여)
 - (2) **의사소통에서의 질적인 장애**(예: 구두 언어의 지연 또는 결여, 대화를 시작하거나 유지하지 못함, 상동증적이고 반복적인 언어사용, 여러가지 가상적 놀이의 결여)
 - (3) **운동성 상동증과 매너리즘을 포함하는 제한적이고 반복적이고 상동증적인 행동, 관심, 활동**
- D. 장애가 다른 특정 광범위성 장애나 정신분열증으로 잘 설명되지 않는다.

6절. 주의력 결핍, 파괴적 행동장애

Attention-Deficit And Disruptive Behavior Disorders

교과서	DSM-4 유아청소년기에 처음 진단되는 장애	DSM-5 신경발달적 장애
1) 운동과다성장애 2) 품행장애 3) 품행과 정서의 혼재성 장애	주의력결핍 및 파괴적 행동 장애 • 주의력 결핍/과잉 행동장애 ① • 상세불명의 주의력 결핍/과잉 행동장애 • 품행장애 ② • 적대적 반항장애 ③ • 파괴적 행동 장애 NOS	주의력 결핍 과잉 행동장애 (ADHD) ①
✓ DSM-4의 품행장애, 적대적 반항장애, 파괴적 행동장애 NOS(상세불명)는 DSM-5에서의 파괴적, 충동조절 및 품행장애에 분류됨		

주의력 결핍 과잉 행동장애 (ADHD) ①

DSM-4 진단기준

- A. (1) 또는 (2) 가운데 1가지 이상이 만족되어야 한다.
- (1) **부주의**에 관한 다음 증상 가운데 6가지(또는 그 이상) 증상이 **6개월 동안** 부적응적이고 발달 수준에 맞지 않는 정도로 지속된다.
- 부주의**
- (a) 세부적인 면에 대해 면밀한 주의를 기울이지 못하거나, 학업, 작업, 또는 다른 활동에서 부주의한 실수를 저지른다.
 - (b) 앉아 있도록 요구되는 교실이나 다른 상황에서 자리를 떠난다.
 - (c) 다른 사람이 직접 말을 할 때 경청하지 않는 것으로 보인다.
 - (d) 지시를 완수하지 못하고, 학업, 간단한 일, 작업장에서의 임무를 수행하지 못한다.
 - (e) 작업과 활동을 체계화하지 못한다.
 - (f) 지속적인 정신력을 요구하는 작업에 참여하기를 피하고, 싫어하고, 저항한다.
 - (g) 활동하거나 속제하는 데 필요한 물건들을 잃어버린다.
 - (h) 외부의 자극에 의해 쉽게 산만해진다.
 - (i) 일상적인 활동을 잊어버린다.
- (2) **과잉행동-충동**에 관한 다음 증상 가운데 6가지(또는 그 이상) 증상이 6개월 동안 부적응적이고 발달 수준에 맞지 않는 정도로 지속된다.
- 과잉행동**
- (a) 손발을 가만히 두지 못하거나 의자에 앉아서도 안정부절못한다.
 - (b) 앉아 있도록 요구되는 교실이나 다른 상황에서 자리를 떠난다.
 - (c) 부적절한 상황에서 지나치게 뛰어다니거나 기어오른다(청소년 또는 성인에서는 안정부절못한다는 주관적 느낌만으로 나타난다).
 - (d) 조용히 여가 활동에 참여하거나 놀지 못한다.
 - (e) 끊임없이 활동하거나 '마지' '자동차에 쫓기는 것'처럼 행동한다.
 - (f) 지나치게 수다스럽게 말을 한다.
- 충동성**
- (a) 질문이 완료되기 전에 성급하게 대답한다.
 - (b) 차례를 기다리지 못한다.
 - (c) 다른 사람의 활동을 방해하고 간섭한다.
- B. 장애를 일으키는 과잉행동-충동 또는 부주의 증상이 **7세 이전**에 있었다.
- C. 증상으로 인한 장애가 2가지 또는 그 이상의 장면에서 존재한다(예: 학교 [또는 직장], 가정에서).
- D. 사회적, 학업적, 직업적 기능에 임상적으로 심각한 장애가 초래된다.
- E. 증상이 광범위성 발달장애, 정신분열증, 또는 기타 정신장애 장애의 경과 중에만 발생하지 않으며, 다른 정신장애(예: 기분장애, 불안장애, 해리성 장애, 또는 인격장애)에 의해 잘 설명되지 않는다.

DSM-5로의 변화: 성인 ADHD에 대한 진단준거 추가. 후기 청소년기나 성인(17세이상)의 경우에는 적어도 5가지 증상이 만족해야 한다.

DSM-5로의 변화: 발병 연령이 7세에서 12세로 늦춰짐.

↑ DSM-4의 기준. DSM-5와 어떤 것이 달라졌는지(회색상자)만 확인!

DSM-5 주의력결핍 과잉행동장애 진단기준

A. 기능 또는 발달을 저해하는 지속적인 부주의 및 과잉행동-충동성이 (1) 그리고/또는 (2)의 특징을 갖는다.

(1) '**부주의**': 다음 9개 증상 가운데 6개 이상이 적어도 6개월 동안 발달 수준에 적합하지 않고, 사회적, 학업적/ 직업적 활동에 직접적으로 부정적인 영향을 미칠 정도로 지속됨

주의점: 이러한 증상은 단지 반항적 행동, 적대감 또는 과제나 지시 이해의 실패로 인한 양상이 아니어야 한다.

후기 청소년이나 성인(17세 이상)의 경우에는 적어도 5가지의 증상을 만족해야 한다

후기 청소년이나 성인은 DSM-5에서 추가된 내용!

1. 종종 세부적인 면에 대해 면밀한 주의를 기울이지 못하거나, 학업, 작업, 또는 다른 활동에서 부주의한 실수를 저지름
(예: 세부적인 것을 못 보고 넘어가거나 놓침, 작업이 부정확함)
2. 종종 과제를 하거나 놀이를 할 때 지속적으로 주의집중을 할 수 없음
(예: 강의, 대화 또는 긴 글을 읽을 때 계속해서 집중하기가 어려움)
3. 종종 다른 사람이 직접 말을 할 때 경청하지 않는 것으로 보임.
(예: 멍백하게 주의집중을 방해하는 것이 없는데도 마음이 다른 곳에 있는 것처럼 보임)
4. 종종 지시를 완수하지 못하고, 학업, 잡일, 또는 작업장에서의 임무를 수행하지 못함
(예: 과제를 시작하지만 빨리 주의를 잃고 쉽게 결길로 셈)
5. 종종 과제와 활동을 체계화하는데 어려움이 있음
(예: 순차적인 과제를 처리하는데 어려움, 물건이나 소지품을 정리하는 데 어려움, 지저분하고 체계적이지 못한 작업, 시간관리를 잘 하지 못함, 마감 시간을 맞추지 못함)
6. 종종 지속적인 정신적 노력을 요구하는 작업에 참여하기를 기피하고 싫어하거나 저항
(예: 학업 또는 숙제, 후기 청소년이나 성인의 경우에는 보고서 준비하기, 서류 작성하기, 긴 서류 검토하기)
7. 과제나 활동에 꼭 필요한 물건들을 자주 잃어버림.
8. 종종 외부자극(후기 청소년과 성인의 경우에는 관련이 없는 생각들이 포함될 수 있음)에 의해 쉽게 산만해짐
9. 종종 일상적인 활동을 잊어버림.
(예: 잡일하기, 심부름하기, 후기 청소년과 성인의 경우에는 전화 화답하기, 청구서 지불하기, 약속지키기)

(2) '**과잉행동-충동성**': 다음 9개 증상 가운데 6개 이상이 적어도 6개월 동안 발달 수준에 적합하지 않고, 사회적, 학업적/ 직업적 활동에 직접적으로 부정적인 영향을 미칠 정도로 지속됨

주의점: 이러한 증상은 단지 반항적 행동, 적대감 또는 과제나 지시 이해의 실패로 인한 양상이 아니어야 한다.

후기 청소년이나 성인(17세 이상)의 경우에는 적어도 5가지의 증상을 만족해야 한다

1. 종종 손발을 만지작거리며 가만두지 못하거나 의자에 앉아서도 몸을 꿈틀거림
2. 종종 앉아 있도록 요구되는 교실이나 다른 상황에서 자리를 떠남.
3. 종종 부적절하게 지나치게 뛰어다니거나 기어오름
(주의점: 청소년 또는 성인에서는 주관적으로 좌불안석을 경험하는 것에 국한될 수 있다.)
4. 종종 조용히 여가 활동에 참여하거나 놀지 못함
5. 종종 “끊임없이 활동하거나” 마치 “태엽 풀린 자동차처럼” 행동함.
(예: 음식점이나 회의실에 장시간 동안 가만히 있을 수 없거나 불편해함, 다른 사람에게 가만히 있지 못하는 것처럼 보이거나 가만히 있기가 어려워 보일 수 있음)
6. 종종 지나치게 수다스럽게 말함.
7. 종종 질문이 끝나기 전에 성급하게 대답함
(예: 다른 사람의 말을 가로챌, 대화 시 자신의 차례를 기다리지 못함)
8. 종종 자신의 차례를 기다리지 못함 (예: 줄서있는 동안)
9. 종종 다른사람의 활동을 방해하거나 침해함
(예: 대화나 게임, 행동에 참견함, 다른 사람에게 묻거나 허락을 받지 않고 다른 사람의 물건을 사용하기도 함, 청소년이나 성인의 경우 다른 사람이 하는 일을 침해하거나 꺾칠 수 있음)

B. 몇가지 부주의 또는 과잉행동-충동성 증상이 **12세 이전에** 나타난다

DSM-4에서는 7세 이전이었음!

C. 몇가지 부주의 또는 과잉행동-충동성 증상이 **2가지 또는 그 이상의 환경에서** 존재한다

(예: 가정, 학교나 직장, 친구들 또는 친척들과의 관계, 다른 활동에서)

D. 증상이 사회적, 학업적 또는 직업적 기능의 질을 방해하거나 감소시킨다는 명확한 증거가 있다.

E. 증상이 조현병 또는 기타 정신병적 장애의 경과 중에만 발생되지는 않으며, 다른 정신질환 (예: 기분장애, 불안장애, 해리장애, 성격장애, 물질 중독 또는 금단)으로 더 잘 설명되지 않는다.

✓ **양상에 따라 부주의 우세형(ADD), 과잉행동-충동 우세형(HD), 복합형(ADHD)로 구분함**

Tripple Pathway Model (Sonuga-Barke, 2010)

ADHD의 기능적 문제를 설명하는 모델

(1) 실행기능계 (배외측 전전두 피질)	- Top down 인지처리에 의한 자극의 억제, 선택, 통제의 곤란 - 노르아드레날린 관여
(2) 보상계 (측좌핵, 전두엽 안와 피질)	- 앞으로의 큰 보수보다 눈 앞의 작은 보수를 선택 - 도파민 관여
(3) 시간처리계 (소뇌)	- 일정시간 내에 계획을 실행하는 것이 곤란, 시간 감각장애 - 노르아드레날린 관여

역학

- 국내 발병율 약 2~4%정도
- 남자가 더 흔함. 여자의 경우 부주의 우세형이 많아서 늦게 발견되기도 함.
- 원인: 유전적 요인, 환경적 요인 등

공병

品行장애	40~70%	우울장애	약 33%
적대적 반항장애		학습장애	20~25%
불안장애	약 25%	뚜렛장애	약 3%
✓ 학습 및 언어장애, 전반적 발달장애, 지적장애, 자폐, 조현병 등에서 과잉행동 증상을 동반하는 경우가 많음.			

ADHD 아동의 특징적 모습

- 아주 어려서부터 까다롭거나 활발했던 경우가 많음
밤낮이 바뀌어 애를 먹었다거나 혹은 하도 '발발거리고' 돌아다녀서 수없이 넘어지고 다치고 애를 먹었다.
대개 '철이없다, 씩씩하다,극성맞다,남자답다' 등의 말을 들으면서 무심코 지나침
- 유치원이나 초등학교에 다니기 시작하면서 단체생활을 시작한 후에야 발견하고 주목하게 됨. 부모보다는 교사들이 먼저 상담을 권유하는 경우가 많음
→ 가정보다 **수십명의 단체생활 중에 훨씬 더 심해지고 눈에 잘 띄기 때문**

임상특징

① 과잉행동 hyperactivity	과잉행동은 나이가 들면서 대근육 운동→소근육 운동, 외적행동→내적운동으로 변화 - 학령전기 아동: 나대고 돌아다님 - 학령기 아동: 꼬무락거림, 자리에서 뒤돌아보기, 말하기, 다른 아이 집적거리기, 연필 입에 물기 - 청소년기엔 대근육 활동 대신 안절부절함으로 대치되기도	
② 부주의 inattention	- 지루하고 반복적인 과제수행에서 특히 두드러짐 - 주의산만함은 학령전기에서 간과되다가 청소년기에 두드러짐 - 학업부진과 이차적인 동기저하를 유발할 수 있음	
③ 충동성 impulsivity	- 주의산만과는 구별되지만 과잉행동과 충동성은 잘 구별되지 않음. - 임상적으로 지시를 끝까지 기다리지 않고 재빨리 반응하는 것 - 부주의한 실수를 초래하는 수가 많음 - 초등학교 고학년이 되면 부산한 모습은 보기 어렵지만, 끈기가 없고 주의산만한 모습과 '욕'하는 충동적인 면은 남아서 성인이 되어서도 문제를 일으키는 수가 많음.	
ETC	학습문제	자신의 지적 잠재력에 비해 성적이 낮고, 과제수행 능력이 매우 부족함 /학년이 높아질수록 두드러짐
	정서문제	스스로 자신의 행동을 통제할 수 없음을 인식하여 자신감, 자존감이 낮아지고 좌절감, 우울감 경험 부모나 교사로부터 부정적인 피드백 형제나 또래와 비교되면서 서운함과 억울함 경험, 분노감이 지속, 반항적인 태도와 행동과 연결
	대인관계 문제	주요 증상들로 인해 주변 성인, 또래와 원만한 관계를 형성하는데 어려움이 있음

ADD(부주의 우세형) vs HD(과잉행동 우세형) (feat. 초등학교 교실의 풍경)

ADD	HD
- 준비물 자주 잊어버리기 - 수업에 집중하지 못하고 멍 때리기 → 집단 규율을 어기는 경우는 드물 교사들에게 화제가 되는 건 집단 행동을 해야할 때 집단에 들어가지 못하고 멍하니 한쪽에 앉아있는 경우	- 선생님이 말씀하시면 “나 그거 들은적 있는데”, “나 그거 아는데”라고 큰소리로 발언하는 아이 - 갑자기 일어나서 지우개 던지기, 친구노트뺏기, 선생님 밀치고 뛰쳐나가기~.. →수업 방해와 본인 보호 등을 이유로 의료기관에 신속히 연결됨

ADD(부주의 우세형) 아이들의 특징

- 온순하고 조용하다
- 표정 몽롱 / 심리적으로 멀게 느껴지는 type / 눈에 잘 띄지 않고 존재감 적은편
- 공부나 특별활동을 열심히 해보고자 하는 의지는 있음
- 본인과 부모님의 가장 큰 고민은 ‘아침에 일어날 수 없다’는 것
 - 깨우는 사람 입장에서 ‘마치 의식을 잃은 듯한’ 느낌
 - 등교거부로 오해받을 수 있으나 기능적 문제.
- 10~20%는 각성장애
- 수면중 노르아드레날린 분비의 저하
- 치료약 : [상품명] Strattera [일반명] Atomoxetine
 - 전두엽 노르아드레날린 수용체에 결합하여 노르아드레날린/도파민 재흡수 저해
 - 수면 중 노르아드레날린 양을 증가시켜 각성 도움

진단

- 자기보고 평가 : 학령전기 아동에서는 얻기 어려우나 청소년기에 인지능력의 발달로 본인의 곤란함을 표현할 수 있기에 활용가능
- 또래관계에서 **자존감(self-esteem)**이나 **사회적 자신감(social competence)**을 손상받는 경우가 많으므로 평가 필요
- 평가척도
 - 코너스 단축형 평정척도(부모, 교사)
 - 지속수행검사: 컴퓨터를 이용하여 어떤 특정한 기호, 숫자, 문자 등을 빠른 속도로 화면에 나타나도록 하면서, 미리 지정된 목표자극에 반응(버튼 누르기)을 하도록 함.-> 정반응수, 주의 분산성, 주의의 일관성 등을 측정

치료

- 2/3에서 청소년기까지, 1/2에서 성인기까지 ADHD가 지속될 수 있음
- 나이가 들에 따라 나아지기를 기대하기 보다 적절한 치료가 필요

(1) 약물치료, 부모교육, 인지행동치료

약물치료	콘서트타	스트라테라	인튜니브
기전	- 중추신경자극약(각성제) - 시냅스간 도파민농도 높임 - 메틸페니데이트 염산염 서방제	- 선택적 노르아드레날린 재흡수 저해제 - 전두엽의 노르아드레날린 농도 높임	선택적 α2A아드레날린 수용체 작용약
규제	규제약	비규제약	비규제약
효과	주의력 결핍, 과잉행동, 충동적 행동에 효과가 빠름 특히 주의력 결핍 증상에 <u>효과</u>	주의력 결핍, 과잉 행동, 충동적 행동에 효과가 있으나 <u>수주간의 투여 시간 필요</u>	과잉행동, 충동적 행동에 효과적, <u>주의력 결핍에는 효과없다.</u> 틱장애 치료에도 처방
부작용	내성, 정신의존성, 수면장애, 식욕부진	교감신경항진증 (빈맥, 고혈압)	부교감신경항진증 (서맥, 저혈압)
etc	효과 빠름	- 내성, 의존성 없음 - 콘서트타보다 효과↓	내성, 의존성 없음

(2) 행동적 접근

- 행동치료 : 강화, 처벌
- 사회적 기술 훈련: 또래와 대화하는 기술, 갈등 해결 기술 등
- 인지-행동적 개입: 자기 통제를 증가시키기 위함
- 부모 훈련 프로그램: 과잉행동의 특성을 교육, 부모의 죄책감을 덜어주고 좌절감과 실망을 다룸

(3) 가정, 교실에서의 효과적 개입

:주변의 산만함을 줄여줌 / 긍정적 행동 보상 / 효과적인 방법으로 지시 / 일상생활 조직화 / 결과를 가르치기 / 부적절한 처벌 절대 금물

경과와 예후

- 예전에는 모두 나이가 들고 자라면 괜찮은 것으로 생각했지만, 추적관찰상 무조건 나이가 들면 괜찮아지는 것은 잘못된 것임이 밝혀짐
- 대인관계 부적응, 학업에 의욕저하, 좌절감, 부정적 자아상, 난폭한 성격 등 유발
- ADHD 3가지 유형의 성인기 예후
 - (1) 성인기에 잘 지내고 일반 성인과 차이를 보이지 않는 군
 - (2) 상당한 정도의 집중력, 사회적, 정서적, 충동적 문제가 지속되면서 **업무상, 대인관계에서 곤란**을 갖는 군. 자긍심 저하, 충동성, 자극 민감성, 불안, 정서가변성도 보임
 - (3) 심각한 정신과 혹은 **반사회적 문제**를 갖는 군. 자살시도, 알코올 남용, 반사회적 행동 등

성인 ADHD의 증상들

- 성장과 함께 주의력 결핍 증세의 변화
 - 의욕이 없고 해야 할 일을 미룬다./ 업무 수행속도가 느리고 비효율적이다. 서로 연관성이 없는 생각이 이어진다.
- 성장과 함께 과잉 행동의 변화
 - 감정이 격해지기 쉽다. / 내면의 안정이나 침착함이 없다. 스스로 아주 분주한 직업을 선택한다./ 목적이 없는 행동을 한다.
- 성장과 함께 충동적 행동의 변화
 - 쉽게 화를 낸다 / 충동적으로 직업을 바꾼다. 운전 중 과속하거나 교통사고를 잘 낸다.

성인 ADHD는 건강한 인간관계 구축이 어렵다. 금전관리 측면에서도 능력이 없어 빚을 많이 지기도 함. 사회적인 지원이 이루어져야한다

品行장애 Conduct Disorder ②

전에 나왔던 내용들이니 여기서부터는 가볍게 보기~

DSM 진단기준

A. 다른 사람이 기본권리나 나이에 적합한 사회규준이나 규율을 위해하는 행동양상이 반복적이고 지속적으로 있으며, 다음 항목 중 **3개 또는 그 이상**이 지난 **12개월간** 있으면서 **최소 1가지 항목**은 지난 **6개월** 동안에 나타난다.

- 사람과 동물에 대한 공격 (7가지)
- 재산파괴 (2가지)
- 사기 또는 절도 (3가지)
- 중대한 규칙위반 (3가지)

B. 행동장애가 사회, 학업 또는 작업기능에 중대한 지장을 초래한다.

C. **18세 이상이면 반사회적 인격장애의 진단기준에 맞지 않아야 한다.**

✓ 발병연령에 따라 유형을 세분화함

소아기 발병형	10세 이전에品行장애 진단기준 가운데 적어도 1가지 충족
청소년기 발병형	10세 이전에品行장애의 어떠한 진단기준도 충족시키지 X

→ 구별하는 이유 : 비정상적인 행위가 어린 나이에 나타나는 경우 특히 예후가 안 좋기 때문

✓ **DSM-5에서는 파괴적, 충동조절 및品行장애로 분류**되었으며 아래 세부사항이 추가됨

• 친사회적 정서결함(=제한된 친화적 정서)

: 이 명시자를 진단하려면 적어도 12개월 이상 다양한 대인관계나 사회적 장면에서 다음 중 적어도 2개 이상의 특징을 보여야 한다.

- 후회나 죄책감 결여
- 냉담, 즉 공감의 결여
- 수행에 대한 무관심
- 피상적이거나 결여된 정서

임상특징

비사회화된 공격성 (undersocialized aggression)	- 부적절한 자기-통제로, 충동 조절능력이 발달되지 못함 - 사회적 도덕적 가치를 습득하지 못하며, 공감능력 결여 - 좌절에 대해 싸움, 불순종, 위협조성, 무분별함, 무례함, 파괴성, 분노폭발
사회화된 폭력 혹은 비행 (antisocial/delinquency)	- 정상에서 벗어난 가치관을 가지면서 사회화됨 - 패거리(gang)가 생활의 중심이 되고 비행친구와 어울린다. - 타인에 대한 감정이해나 통제가 부족한 것은 아님
부모-아동간 상호작용	- 강압모형(coercion theory) '강화의 덫' - 부모는 부적강화를 통해서 아동의 부정적 행동강화 - 부모-자녀간 공격과 반격의 강도가 점차 증가되며, 이는 다시 앞으로의 부정적인 상호작용의 재발가능성을 증가시킴 - 아동은 외현적인 행동화 방식으로 문제해결하려 하며, 자기-조절의 내면화가 안됨
부모역할 훈련	- 부모-자녀 상호작용을 긍정적인 방향으로 변화시키는 것이 효과적 - 처벌 방법을 [강력/체벌] → [일시적 특권박탈]과 같은 약한 방법으로 대체
사회문제해결기술 훈련	- 반사회적 아동이 대인관계 문제해결 능력이 빈약하므로 - 인지행동 치료가 효과적 → 대안만들기, 결과생각해보기, 타인 입장 생각해보기, 역할놀이와모델링

경과 및 예후

초기발병 vs 후기발병	10세 이전 발병 품행장애 남아는 후기 발병 청소년보다 공격적 증상을 보일 확률이 8.7배 더 높음 - ADHD, 반항성 장애 증상이 있는 경우 품행장애 더 일찍 발병 - 품행장애는 반항성 장애 증상이 미리 있는 경우에 일찍 발병함.
증상의 심각도	- 여러 가지 비행의 심각도 척도가 예후 예측에 유용 13세 이전 아동에서 잔인함, 가출, 건물침입의 증상이 품행장애를 잘 예견함.
공격성(싸움) vs 비공격성(도둑질)	육체적 싸움이 품행장애 발병을 잘 예측함
공병 & 공증	- ADHD를 함께 갖는 남아의 예후는 나쁨 - 무정한 증상과 품행장애를 겸한 아동이 품행장애만 지닌 아동보다 문제를 많이 일으킴

적대적 반항 장애 Oppositional Defiant Disorder (ODD) ③

DSM 진단기준

- A. **거부적, 적대적이고 반항적인 행동양상이 최소한 6개월간 지속되며**, 다음 중 4개 이상의 증상이 있음 (생략)
- B. 행동장애가 사회, 학업, 또는 직업기능에 중대한 지장을 초래
- C. 문제행동이 주로 정신질환이나 기분장애의 발병과정에서 발생하는 것이 아니다.
- D. **행실장애의 진단기준에 맞지 않고, 18세 이상이면 반사회적 인격장애의 진단기준에 맞지 않아야 한다.**
- ✓ DSM-5에서는 파괴적, 충동조절 및品行장애로 분류되었고
- ✓ 진단기준에 3가지로 증상을 그룹화함
 - 1) 분노/과민한기분
 - 2) 논쟁적/반항적 행동
 - 3) 보복적인 양상

임상특징

- **의도성**: 단순한 불복종이 아니라, 어른의 요구나 지시, 금지에 **의도적으로 따르지 않음**
- **주요한 사회적 규범이나 규칙 또는 타인의 기본적 권리를 침해하지는 않음**
- 타인과 기본적 애착을 형성하고 있음
- 자율성 문제가 핵심
 - 주도성, 자율성 발달을 통해 자기통제와 자기신뢰를 발달 시켜줘야함
- **후에品行장애로 발전될 가능성이 높음**
- 복종을 유도하는 지시
 - 지시 전에 **아동의 주의를 끌고, 어떠한 변화가 일어날 것임을 미리 알려줌**
 - 분명하고 세부적인 지시를 함
 - 지시를 내리고 난 다음에는 아동이 따를 수 있는 시간적 여유를 줌
 - **조급하게 제시되는 간섭적인 지시는 반항을 유발**
 - 불복종에 벌을 주기보단 **복종행동에 칭찬, 승인이 효과적**

7절. 유아기 또는 초기 소아기의 급식 및 섭식장애 Feeding and Eating Disorders of Infancy or Early Childhood

교과서	DSM-4 유아청소년기에 처음 진단되는 장애	DSM-5 신경발달적 장애
7) 소아 및 청소년기 발병의 기타 행태와 정서장애 (3) 유아/소아기의 섭식장애 (4) 유아/소아기의 이식증	유아 또는 초기 소아기 의 급식 및 섭식장애 이식증 반추장애	급식 및 섭식장애에 포함됨

DSM-4 -> DSM-5

- 아동기 장애(이식증, 반추장애)와 성인기 장애를 통합하였음
- 거식증을 신경성 거식증, 회피적/제한적 음식섭취장애로 세분화
- 폭식증을 신경성 폭식증, 과잉섭취장애로 세분화

- ① **Pica(이식증)**
- ② **Rumination disorder(반추장애)**
- ③ Avoidant/Restrictive food intake disorder(회피/제한적음식섭취 장애)
- ④ Anorexia Nervosa(신경성 식욕부진증)
- ⑤ Bulimia nervosa(폭식증)
- ⑥ Binge Eating disorder(폭식장애)
- ⑦ Other specified feeding or eating disorder
- ⑧ Unspecified feeding or eating disorder

섭식장애

- 성장실패로 이어짐
- **지속적으로 섭식에 실패하는 것으로, 최소 한달간 몸무게 증가가 없거나 감소한 경우**
- **6세 이전에 시작된 경우**
- 영양부족으로 건강상태가 나쁘고, 자주 감염되고 병으로부터 회복력이 약함
- 우울, 위축, 슬프고 무감각, 지나치게 조심하고 과민, 화난 것 같아 보임
- 성장실패기간이 짧을수록, 치료로 인한 최초 성장속도가 빠를수록 예후가 좋음
- 아동기와 청소년기에 섭식장애(거식증)로 발전할 가능성이 있음

원인

- 성장에 필요한 영양과 칼로리 공급이 적절하지 못함
 - 기질적문제(지나친 신진대사, 영양흡수 부족)
 - 적절히 영양을 제공하지 못함
- 혼란된 양육자-영아관계, 영아학대, 여러 가족문제
 - 양육자: 정서장애, 물질남용과 성격장애, 불안정 애착패턴
 - 가족,양육: 영아-어머니간 불안정 애착비율이 높음
 - 부적절한 주거, 빈번한 이사, 가난, 아동학대와 사회적 고립에 노출 多

이식증 Pica

- 진흙, 먼지, 모래, 돌, 머리카락, 대변 등 먹을 수 없는 것을 반복적으로 먹는 것
- 적어도 **1개월 이상** 지속되어야 함
- 소아의 약 10-20%가 이식증을 나타내며, 연령이 증가하며 감소
- 대개 12-24개월에 걸음마기 동안 시작됨 (영아들은 물건을 입에 흔히 갖다 대므로 영아에서 이식증의 진단을 내리기 쉽지 않음)
- **지적장애, 자폐아동이 이식증을 나타낼 확률 높음**
- 아동기, 청소년기에 섭식장애 (폭식증)로 발전할 가능성 있음

반추장애 Rumination disorder

- 음식을 자발적으로 반복적으로 토하며
- 토한 것을 자기몰입하여 편안하고 즐거운 상태에서 다시 씹고 삼키는 경우
- 대개 **3개월에서 12개월 사이에 시작**
- 대개 조용히 누워서 행복해보임 (자기만족, 반추에 몰두해 있음)
- **원인**
 심리적 요인: 부적절한 양육환경과 관련됨
 자기자극적인 경우: 지적장애와 관련됨
- **반추장애 영아의 25%는 지적장애, 전반적 발달장애와 같은 발달장애를 보임**
- **감별진단: 소화기질환이 있는지**
 반추장애 영아는 행복해보이고 역류를 즐기는 듯 보이지만, 소화기 질환이 있는 경우는 구토할 때 불편해하고 고통을 나타냄

8절. 배설장애 Elimination Disorders

교과서	DSM-4 유아청소년기에 처음 진단되는 장애	DSM-5
7) 소아 및 청소년기 발병 의 기타 행태와 정서장애 (1) 비기질성 유뇨증 (2) 비기질성 유분증	• 배설장애 -유분증 -유뇨증	배설장애를 따로 아동기 장애 에서 독립시킴 • 배설장애 -유뇨증 -유분증 -기타 특정/불특정 배뇨장애

유분증 Encopresis

DSM-5

- A. 부적절한 곳(옷이나 바닥)에 불수의적이든 의도적이든 **반복적으로 대변**을 본다.
- B. 적어도 **3개월 동안에 월 1회 이상** 나타난다.
- C. 생활연령이 적어도 **4세 이상**이다 (또는 이와 동일한 발달수준에 있음)
만 4세 이상에 진단 내릴 수 있음!
- D. 이러한 행동은 물질(예;완화제)의 생리적 효과나 변비를 일으키는 기전을 제외한 다른 의학적 상태로 인한 것이 아니다.

유형

- 1차성, 2차성
- 정체성(변비 동반), 비정체성(변비X) → 변비 치료를 같이 해주는 것이 중요
- 대변을 적절하게 가릴 수 있는데도 적절하지 못한 곳에 지리는 경우
- 전혀 대변에 대한 변의를 느끼지 못하거나, 변이 나오는 것을 느끼지만 조절능력이 없는 경우
- 정체성 유형으로 대변이 장내에 축적되어 대장이 계속 확장되고, 이로 인하여 장벽의 수축력이 약화되고 변이 쌓이게 되어 변비가 오는 경우
- 화장실을 사용하는 것에 대한 공포감이 있어서 적절한 장소에 대변을 보지 못하는 **화장실 공포증**에 해당되는 아이들

유분증

- 대개 4세 이전에 약 95%의 아동이, 5세가 되면 99% 아동이 대변을 가림
- 남아에서 여아에 비해 3~5배 많음
- 유병률: 국내 초등학교 아동에서 2.4%
- 공병
 - 유분증이 있는 아동의 약 1/3~1/4는 유뇨증을 가지고 있음
 - 지적장애, 반항장애, ADHD, 불안장애, 우울장애 등

- 감별진단
 - 내과적 질환이나 평활근 장애, 내분비 이상 등을 감별해야 함
 - 간혹 ADHD 아동에서 배변에 대한 자극에 미처 주의를 기울이지 못하거나 뒤늦게 화장실로 가는 중에 변을 지리는 경우도 있음.
- 여러연구들에서 교육적, 심리적, 행동적 접근을 복합하였을 때 60~80%의 성공률을 보고하고 있음
- 유뇨증에서와 마찬가지로 신체적, 정신적 성숙에 따른 자연경감도 상당부분 존재

유뇨증 Enuresis

DSM-5

- A. 침구 또는 옷에 불수의적이든 의도적이든 **반복적으로 소변**을 본다.
- B. 적어도 **연속된 3개월 동안 주 2회 이상** 나타나고, 사회적, 학업적(직업적) 또는 다른 중요한 기능 영역에서 임상적으로 현저한 고통이나 손상을 초래한다.
- C. 생활연령이 적어도 **5세 이상**이다. (또는 이와 동일한 발달수준에 있음)
- D. 이러한 행동은 물질(예;이뇨제, 항정신병 치료약물)의 생리적 효과나 다른 의학적 상태(예; 당뇨, 척수이분증, 발작장애)로 인한 것이 아니다.

✓ **만 5세 이상이 되어야 진단 가능**

유형

일차성 유뇨증	소변가리기가 한번도 성공적이지 못했던 경우
이차성 유뇨증	일년이나 그 이상 일정기간 분명하게 소변을 가린 후 못가리게 되는 경우

원인

기질	팔약근의 기능부전, 진성 당뇨병, 비뇨기계 감염, 신경근육계 발달 지연 자세한 병력과 비뇨기과적 이상에 대한 정밀검사를 통해 드물지만 기질적 원인을 확인해야 함 가족력이 있는 경우도 있음(유전가능성 암시)
성격	과잉활동적, 공격적, 반항적, 좌절에 대한 인내심 부족, 의존적, 낮은 성취동기와 숙달동기
부모	무관심, 방관-허용적, 성취에 대한 요구가 낮고 불안정, 배뇨의 버릇을 너무 엄하게 가르치거나 일찍 서두른 결과 (심리적 stress로 작용)

감별진단

- 당뇨, 요붕증 등이 있어서 소변 만들어내는 양이 너무 많은 경우
- 간질이나 몽유병 등으로 인한 의식과 수면의 장애
- 이뇨제나 항정신병약물 복용하면서 약물 부작용에 의해 나타나는 경우
- 비뇨기계 감염, 방광생리기능의 변화

치료

- 5~6세경 아동들은 증상의 정도가 심하지 않으면 일단 기다려 보는 것이 좋음
- 7세 이후의 아동들에게 적극적인 치료 시도하는 경우 多
- 원인을 알려주거나 안심시키는 것만으로도 좋아지는 경우도 多
- 약물치료
- 행동치료
 - 밤에 소변보도록 아이를 주기적으로 깨우면서 지지나 격려하기
 - 자기전에 음료수 먹지 않기
 - 이불경보방법: 이불을 적시면 경보가 울리고 아동을 깨워 화장실에 보냄 - 반복하면 경보가 울리기전에 미리 깨게 됨
- 복합적 방법: 강화, 적절한 소변보기 연습, 참기조절훈련, 자다 깨기, 벌, 경보

9절. 기탁장애

DSM-4 유아청소년기에 처음 진단되는 장애	DSM-5
• 기탁 유·청소년기 장애 -분리불안 장애 -선택적 함구증 -반응성 애착장애 -상동증적 운동장애 -유·소아청소년기 장애 NOS	-분리불안장애와 선택적 함묵증이 불안장애로 포함됨 -반응성 애착장애, 탈억제 사회관여장애가 외상 및 스트레스 관련 장애로 포함됨 -상동증적 운동장애는 운동장애에 포함됨

분리불안장애 Separation Anxiety Disorder

- 정상발달(대상영속성, 대상항상성) -> 분리불안 감소, 주도성의 급증
- **본질적인 특징은 가족구성원 or 주양육자로부터의 분리**에 대한 과도한 걱정
- 불안은 아동이 애착대상과 함께 있을 때에는 경감
- 18세 이전에 발병해야 진단되나, 10세 이후에는 발병이 흔치 않음
- 유병율 3~5%, 여아>남아
- **5~9세**에 전형적으로 발병, 평균연령 9세 (연령증가에 따라 감소, 청소년 2%↓)

5~8세 아동	애착대상에게 일어나는 피해나 악몽, 등교거부 증상: 울기, 사회적 철수, 분노발작, 두려움 등 주제: 길을 잃는 것이 전형적, 그 외 질병, 죽음, 유괴, 폭행 등의 위험에 대한 두려움을 나타냄
9~12세 아동	분리되어 있는 동안 과도한 스트레스와 고통, 등교거부, 신체증상 증상: 잦은 질병 호소, 학교가는 날 잊기, 사회적 철수 등 약 75%에서 학교거부증(school refusal), 학교공포증(school phobia)으로 나타남

✓ 원인

- 1) 기질적 취약성 : 불안하고 두려워하는 기질
- 2) 불안정한 애착 : 부모와 아동간 과도한 밀착관계
- 3) 스트레스 요인 : 통제가 어려운 정도의 분리경험 ex. 사랑하는자의 상실
- 4) 모델링(사회학습 이론) : 부모의 불안을 학습한 경우

선택적 함구증 Selective Mutism

- 편안하고 이완된 상황에서는 말과 의사소통을 할 수 있음
- 가까운 사람과는 집에서 말을 함
- 일단 밖으로 나가거나 특정상황에서 입을 꼭 다물고 전혀 말을 하지 않음
- 어떤 아동들은 가끔 말을 하거나 속삭일 수 있음
- 상황: 타인에게 소개될 때, 괴롭힘을 당하거나 비판받을 때, 자신에게 관심이 집중될 때, 관심을 끌어야 할 때 불편해함
- **관계형성 : 대부분 친구를 원하고 필요로 함**
- 신체적 증상 : 복통, 구역구토, 관절통, 두통, 흉통, 현기증, 긴장감, 두려움 등
- 외관: 경직되고 어색한 몸짓, 굳은표정, 무표정, 눈맞춤을 피함
- **선택적 함묵증을 지닌 아동의 90% 이상이 사회적 공포증이나 불안감을 지님**
- 유병율: 0.08~0.72%
- 대개 3~7세 발병 (평균연령 3세 4개월)
- 남 : 여 = 1 : 4.8(한국), 1:2(외국)
- 연령의 증가와 함께 자연히 해결되는 경우가 많음

DSM-5

- A. 다른 상황에서는 말을 할 수 있음에도 불구하고, 말을 해야 하는 **특정한 사회적 상황(예: 학교)에서 일관되게 말을 하지 않는다**
- B. 장애가 학습이나, 직업상의 성취 혹은 사회적 의사소통을 방해한다.
- C. 장애가 **적어도 1개월**은 지속된다. (학교생활의 첫 1개월에만 국한되지 않는 경우)
- D. 사회적 상황에서 필요한 말에 대한 지식부족하거나, 언어가 익숙하지 않은 것으로 인해 말을 하지 않는 것이 아니다.
- E. 장애가 의사소통 장애(예: 아동기 발병 유창성 장애)로 더 잘 설명되지 않고, 자폐스펙트럼 장애, 조현병 또는 다른 정신병적 장애의 경과 중에만 발생되지는 않는다.

유형 (생략)

공생적 함묵증	어머니와 강한 공생적 관계를 유지하며, 요구를 관철시키기 위해 엄마에게 매달리고 수줍어하고 예민하게 행동
수동-공격적 함묵증	침묵을 무기로 말하는 것을 거부
반응적 함묵증	환경의 변화나 외상 후에 갑자기 말을 안함
언어공포증적 함묵증	"내 목소리를 남이 들으면 이상하지 않을까?"

원인

- 아이에게 충격적 사건, 환경의 변화와 같은 명백한 유발 인자
- 가족내 갈등의 결과로 나타난다고 주장하는 연구자도 있음
- 유전적 소인: 가족 중 불안장애

치료

- 수줍은 아이들은 새로운 환경에서 일시적으로 말을 하지 않을 수 있음
- **증상이 6개월 이상 지속되는 경우** 치료적 개입
- 행동적 접근 : 긍정적 보상으로 말하는 횟수를 늘림. 가장 친숙한 사람으로부터 점차 친숙하지 않은 사람으로 대화를 확대해 나감
- 지지적 접근 : 아이가 갖고 있는 갈등을 자연스럽게 표출하고 치료자와 가까운 관계 형성
- Rhea Paul의 10단계 치료기법(2001) (**참고**) **점차적으로 말을 하게끔 하는 단계**
- 가정이나 학교에서 주의해야 할 사항
 - 말하도록 하기 위해서 보상이나 벌을 주는 것은 오히려 역효과를 낼 수 있음**
 - 아동을 가급적 규칙적인 집단 활동에 참여시킴
 - 아동이 편하게 느끼는 상황에서 책읽기, 이야기 꾸미기 놀이 같은 자연스러운 말하기 활동을 장려
 - 집과 학교에서 성인과의 비언어적인 의사소통 활동을 격려함
 - 말할 기회가 주어져야 하나 강요해서는 안 됨

반응성 애착장애 Reactive Attachment Disorder

- 대부분의 대인상황에서 현저하게 비정상적이고 발달학적으로 부적절한 대인관계
- 양육자에게 위안을 구하는 발달학적으로 정상적인 경향을 억제함
= 양육자에게서 애착을 구하지 않음. 엄마랑 떨어져도 울지 않고 관심이 없음
대인관계에서의 반응이 억제되고 경계적이거나, 심하게 양가적
- cf) 탈억제성 사회적 유대감 장애: 애착체계가 과활성화되어, 특정 애착 대상에 국한되지 않은 **무분별한 애착행동**을 보임: 아무에게나 과도한 친밀성(선택성 결여)
- 병적인 양육의 결과(아동을 돌보지 않고 방치하거나 학대하는 환경)**
- 5세 이전에 시작됨**

애착발달단계

[출생] ~ [8주-3개월]	무분별한 사회적 반응단계 - 주로 후각과 청각에 의존 - 유아가 양육자를 제한적으로 구분
[8주-3개월] ~ [6-8개월]	변별된 사회적 반응단계 - 분별적인 대인반응 사회적 미소, 시각적 반응 증가 - 누구에게든 안길 수 있고 낯선이에 의해 달래질 수 있음
[6-8개월] ~ [18-24개월]	적극적, 능동적인 접근과 접촉추구의 단계 - 낯선 사람에 대한 두려움, 양육자에 대한 선호 - 양육자와 분리 시 강하게 저항 집중적 애착 형성
[18-24개월] ~ [3세]	목표-수정적 동반관계 대상항상성 획득 - 언어발달과 함께 복잡한 협조관계 수립

DSM-5

1) 반응성 애착장애 **빨간 글씨만!**

DSM-5 진단기준

- A. 성인 보호자에 대한 **억제되고 감정적으로 위축된 행동**의 일관된 양식이 다음의 2가지 모두로 나타난다.
1. 아동은 정신적 고통을 받을 때 거의 안락을 찾지 않거나 최소한의 정도로만 안락을 찾음
 2. 아동은 정신적 고통을 받을 때 거의 안락에 대한 반응이 없거나 최소한의 정도로만 안락에 대해 반응함
- B. 지속적인 **사회적·감정적 장애**가 다음 중 최소 2가지 이상으로 나타난다.
1. 타인에 대한 최소한의 사회적·감정적 반응성
 2. 제한된 긍정적 정동
 3. 성인 보호자와 비위협적인 상호작용을 하는 동안에도 설명되지 않는 과민성, 슬픔 또는 무서움의 삽화
- C. 아동이 **불충분한 양육의 극단적인 양식**을 경험했다는 것이 다음 중 최소 한 가지 이상에서 분명하게 드러난다.
1. 성인 보호자에 의해 충족되는 안락과 자극, 애정 등의 기본적인 감정적 요구에 대한 지속적인 결핍이 사회적 방임 또는 박탈의 형태로 나타남
 2. 안정된 애착을 형성하는 기회를 제한하는 주 보호자의 반복적인 교체(예, 위탁 보육에서의 잦은 교체)
 3. 선택적 애착을 형성하는 기회 고도로(심각하게) 제한하는 독특한 구조의 양육(예, 아동이 많고 보호자가 적은 기관)
- D. 진단기준 C의 양육이 진단기준 A의 장애 행동에 대한 원인이 되는 것으로 추정된다(예, 진단기준 A의 장애는 진단기준 C의 적절한 양육 결핍 후에 시작됐다).
- E. 진단기준이 자폐스펙트럼장애를 만족하지 않는다.
- F. 장애가 **5세 이전에** 시작된 것이 명백하다.
- G. 아동 발달 연령이 최소 **9개월 이상**이어야 한다.

2) 탈억제성 사회 관여장애 **빨간 글씨만!**

DSM-5 진단기준

- A. 아동이 **낮선 성인에게 활발하게 접근하고 소통**하면서 다음 중 2가지 이상으로 드러나는 행동 양식이 있다.
1. 낮선 성인에게 접근하고 소통하는 데 주의가 약하거나 없음
 2. 과도하게 친숙한 언어적 또는 신체적 행동(문화적으로 허용되고 나이에 합당한 수준이 아님)
 3. 낮선 환경에서 성인 보호자와 모험을 감행하는 데 있어 경계하는 정도가 떨어지거나 부재함
 4. 낮선 성인을 따라가는 데 있어 주저함이 적거나 없음
- B. 진단기준 A의 행동은 (주의력결핍 과잉행동장애의) 충동성에 국한되지 않고, 사회적으로 탈억제된 행동을 포함한다.
- C. 아동이 **불충분한 양육의 극단적인 양식**을 경험했다는 것이 다음 중 최소 한 가지 이상에서 분명하게 드러난다.
1. 성인 보호자에 의해 충족되는 안락과 자극, 애정 등의 기본적인 감정적 요구에 대한 지속적인 결핍이 사회적 방임 또는 박탈의 형태로 나타남
 2. 안정된 애착을 형성하는 기회를 제한하는 주 보호자의 반복적인 교체(예, 위탁 보육에서의 잦은 교체)
 3. 선택적 애착을 형성하는 기회 고도로(심각하게) 제한하는 독특한 구조의 양육(예, 아동이 많고 보호자가 적은 기관)
- D. 진단기준 C의 양육이 진단기준 A의 장애 행동에 대한 원인이 되는 것으로 추정된다(예, 진단기준 A의 장애는 진단기준 C의 적절한 양육 결핍 후에 시작됐다).
- E. 아동의 발달 연령이 최소 **9개월 이상**이어야 한다.

감별진단

- 애착이 다른 질환(품행장애, 우울증)과 연관되어 단지 문제가 있는 정도가 아니라, 애착자체가 병적이라고 볼 것인가를 결정하는 것이 어려움
- 전반적 발달장애(=자폐스펙트럼장애)와의 비교

반응성 애착장애	전반적 발달장애
• 정상적 대인관계를 할 수 있는 기회가 부족했던 것이지 능력이 없는 것은 아님 • 정상적인 성장 환경에서는 사회성이 회복될 수 있음 • 양육환경이 호전되면 인지능력 결함도 나아짐	• 현저한 의사소통과 언어능력에 이상이 있음 • 한정된, 반복적이고, 상동증적인 양식의 행동과 흥미와 활동이 지속되는 것이 특징적임.

애착장애 치료 프로그램

(1) 양육자의 민감성을 증진	아이의 신호를 무시하지 않고 정확히 해석/반응
(2) 양육자의 내적 표상 바꾸기	양육자의 내적 부모-자식 관계모형 안정화
(3) 사회적 지지의 공급	미혼모, 가난, 조산아 등 사회적 지지가 필요한 층에게 직접 공급
(4) 양육자의 정신건강 증진	양육자의 불안, 우울 치료

10절. 소아 관련 증후 (참고)

- 각종 證候의 발생에 가장 중요한 것은 정서적 요인 (七情),
- 특히 갑자기 놀라는 것인 '驚'
- 소아는 기본적으로 氣血이 弱한데 갑자기 놀라게 되면 '驚則氣亂'하여 그 神氣가 어지럽게 흩어져 각종 증상이 발생
- <유과발휘> 소아의 정서적 요인은 아직 완성되지 않았는데 갑자기 두렵고 놀라움을 당하면 소아의 의식, 감정의 요소인 혼백이 제멋대로 되어 경련과 강직의 증상이 나타난다.

癇 -간질발작

- 胎病, 즉 妊婦의 문제로 임부가 크게 놀라 생긴다고 보았음

驚風

급경풍	• 간질을 제외한 소아의 급성경련성 질환 • 갑자기 낯선 사람이나 물건을 접하거나, 이상하거나 큰 소리를 들어 놀란 것이 화담, 담생열, 열극생풍하여 발생 • 경, 풍, 담, 열이 주요 병리인자
만경풍	• 큰 병을 앓은 후나 오랫동안 토사를 하여 비위기능에 영향을 주어 진액을 휴손하였을 때, 이것이 간혈에 영향을 주어 혈불양근하여 강직과 경련을 일으키는 병

客忤, 中惡 (객오, 중악)

- 새롭거나 익숙하지 않은 것에 대한 일종의 적응문제
- 소아는 '심기부족'하여 심리적으로 안정되지 않았는데, '異物 暴觸驚(이물 폭촉경)', 즉 평소에 접하지 않던 것에 갑자기 놀라서 생기는 것
- 중악은 객오보다 증상이 심한 경우

夜啼 야제

- 밤에 발작적으로 우는 것으로 육구나 고통에 대한 반응, 특히 수면장애의 원인으로 작용
- 脾寒, 心熱, 口瘡重舌, 客忤

遺尿 유뇨

- 허한으로 인한 것으로 보고 온보의 치법을 사용
- 경악: 유뇨를 소아에 있어 발달지연의 문제로 보고 있음
- 습관처럼 유뇨하는 것은 아이의 소변가리는 것에 대한 意志의 문제
-인지발달의 문제와 함께 어느정도 심리적인 문제임을 제기

五遲·五軟 오지·오연

- 현대에서 소아발달장애와 지적장애와 연관된 개념으로 연구됨.

- 오지

立遲 입지	서는 것이 느림
行遲 행지	걷는 것이 느림
髮遲 발지	모발이 자라는 것이 느림
齒遲 치지	치아가 나는 것이 느림
語遲 어지	말이 느림

ADHD

분류	주의력 결핍	과잉운동. 충동성
정신과 육체의 조절	정신적 주의집중력 저하 산만함	육체적 활동 과잉 충동적 제어부족 변화무쌍
한의원변증	양기부족 기력부족 기증 담음	음기부족 음허화동 실증 화/열/조
관련 증상	건망증 기허 노관상 담음	정충 경계 번조 허번증 음허화동 섬어 축혈증

- ADHD에 사용된 한약처방 순위(참고)

No.	처방	효능	변증
1	속지황, 산약, 산수유, 목단피, 진피, 복령	온양보신, 건비이기화담, 냉심안신	간신음허증, 비기부족, 담탁내조
2	익지인, 하수오, 석창포, 원지	보간신, 화담개규, 안신익지	간신음허증, 담탁내조
3	별갑, 황백, 지모, 산조인	자음잠양강화, 양혈보심, 안신	간신음허증, 허양화성
4	여정자, 구기자, 울금, 시호, 단삼	자보간신, 소간해울, 행기활혈, 청심안신	간신음허증 간기울결, 어열호결
5	당삼, 맥문동, 오미자	보익심비신, 익기양음, 냉심, 청심안신	심비양허증 기음허
6	당귀, 황기, 백출	건비보기, 양혈	심비양허증, 기혈허
7	감초, 대조, 옹골, 모려, 복신	양심, 냉심, 중진안신, 화중완급, 평간잠양	심비양허 심신부영

변증을 주로 간신음허, 심비양허로 한 것을 알 수 있음!

- 단일약제로는 안신, 보기 보혈 약제를 씀
- 침치료는 백회, 사신총 등

자폐스펙트럼 장애

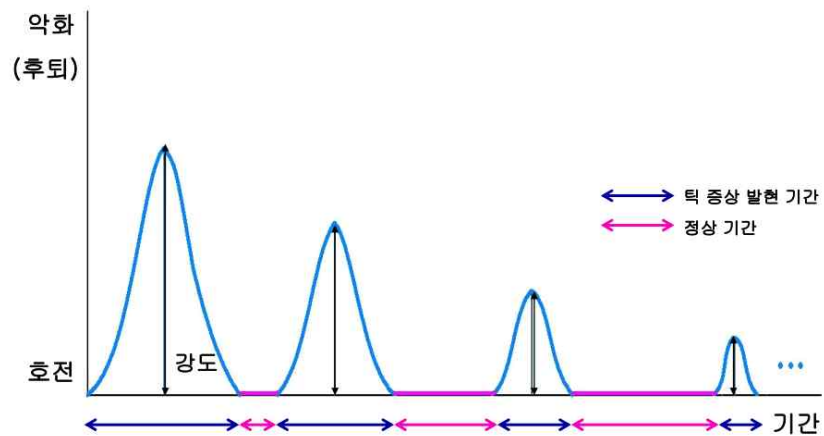


허증과 실증을 나눔
양방에서도 치료약이 없어서 긴장
감이나 과민 등의 증상을 경청하고
수용하는 것이 필요함.
심리적으로 지지해주기

틱장애

- 심담허겁(불안, 예민한 기질), 기울결(불편한 느낌, 전조감각충동), 담음, 칠정상(스트레스), 열, 허증

틱장애의 증상	한의학적 분류
1. 근육틱 [눈] ① 눈깜박거림-가장 흔한 초기증상 [얼굴과 머리] ② 이마를 찌푸리거나 ③ 눈을 깜박거리거나 ④ 코에 주름살을 짓거나 ⑤ 입술을 빨거나 ⑥ 얼굴근육을 씹거나 ⑦ 머리를 고집하거나 흔들고 ⑧ 목을 비트는 행동 [몸체] ⑨ 어깨를 들썩이거나 ⑩ 무릎이나 발을 흔드는 행동	筋傷肉瞤 目瞤 目閃 目瞤(목차) 目連筋 目連扎(목연찰) 胞輪振跳 瞤動 筋傷肉瞤
2. 음성틱 [음성] ① 목안을 씻어내는 듯한 마른기침 ② '음음', '궁궁', '악' 하는 소리를 내거나 ③ 개 짖는 소리 ④ 코를 킁킁거리거나 ⑤ 입술을 빠는 소리 ⑥ 입맛 다시는 소리	異常聲音 乾咳(乾嗽, 火咳, 鬱嗽), 梅核氣 呻吟 天籟鳴(천뇌명)



틱장애는 악화되는 양상이 있기 때문에 치료하고 바로 좋아지지 않는다고 해도 걱정하지 말자